



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO 1A INST CIV COM 19A NOM

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 30

Año: 2024 Tomo: 1 Folio: 275-305

EXPEDIENTE SAC: 11686041 - MARRERO, MARIA SOL C/ DIAZ, MARIA BELEN Y OTRO - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUICIOS - MALA PRAXIS - TRAM.ORAL

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 30 DEL 21/03/2024

SENTENCIA NUMERO: 30. CORDOBA, 21/03/2024.

Y VISTOS:

Los autos caratulados **MARRERO, MARIA SOL C/ DIAZ, MARIA BELÉN Y OTRO - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUICIOS - MALA PRAXIS - TRAM.ORAL** (Expte. Nº 11686041), de los que resulta que:

1.- Con fecha 15/02/2023 la Sra. Maria Sol Marrero, con el patrocinio letrado de la Dra. Paola L. Casas, promueve demanda en contra de la Sra. María Belén Díaz (DNI 27.655.581) y “Clínica Veterinaria Hakuna Matata”, reclamando la suma de \$ 262.216, supeditada a lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse, con más los intereses correspondientes y costas.

Relata los hechos que dan fundamento a su pretensión en los siguientes términos: « *He sido la guardadora responsable cuidadora y propietaria de Lola -perra caniche sin pedigrí- durante cinco (5) años, la cual tuve desde que tenía apenas un mes y medio de vida, habiendo sido ella un regalo de una amiga de la infancia Maricel Lencina. La fecha de su nacimiento fue el 20/07/2014 tal surge del carnet sanitario que en este acto acompaño y la fecha de su muerte fue el 13/07/2020.*

2. *Tal como surge de la documentación que acompaño, tales como certificados de*

vacunación, controles periódicos, peluquería canina y por otros medios probatorios tales como fotos y testimoniales que produciré en el presente proceso, acreditaré que el bienestar que le brindaba a Lola era evidente y elocuente.

3. Con fecha 01/07/2020 llevé a mi perrita Lola (caniche de 5 años de edad) a la veterinaria llamada “Hakuna Matata” sita en calle Av. Armada Argentina N° 209 de B° Las Flores a cargo de la Med. Vet. Mat. Prof. 2638 María Belén Díaz, quien luego de revisarla consideró que Lola tenía infección en las vías respiratorias, medicándola por ello con dos inyectables cuyos nombres y tipo desconozco e indicando un tratamiento ambulatorio vía oral consistente en: medio comprimido cada 12hs. por el lapso de 7 a 10 días del medicamento denominado “Bactroprofen”.

4. Una vez iniciado este tratamiento, el cuadro de afección de salud inicial de Lola, lejos de mejorar empeoró, experimentando complicaciones: vómitos constantes, desarreglo intestinal (diarrea), malestar, alta temperatura (fiebre) y decaimiento.

5. Fue por ello que decidí regresar a la veterinaria a los dos días, según indicaciones de la Dra. María Belén Díaz, allí indicó cambiar de fármacos, inyectando nuevamente otro medicamento sobre Lola (cuyo nombre no me dijo) y a partir de esta última visita debía darle vía oral el antibiótico “Enrofloxacin” 50mg: medio comprimido cada 24 hs. por 10 días.

6. Luego de ello, el cuadro de Lola se mantenía con leve mejoría, pero continuaba decaída y con temperatura, motivo por el cual nuevamente decidimos regresar a la Veterinaria Hakuna Matata el 06/07/2020. Recién en esta tercera oportunidad la Méd. Vet. Díaz decidió realizar análisis de laboratorio: sangre, por lo cual se realizó la prueba según sus indicaciones y con fecha 07/07/2020, los resultados arrojaron una “infección” por la que Lola transitaba.

7. Al comunicarle a la Dra. Díaz los resultados, manifestó que podría ser de útero, si bien había incertidumbre acerca del origen y por eso sugirió realizar una ecografía con fecha 10/07/2020 la cual se llevó a cabo en la misma Veterinaria y allí expresó e indicó la Méd. Vet. Díaz, la necesidad de castrarla.

8. Aun así, pese a la insistencia por la castración para Lola como solución a su cuadro, no expresó diagnóstico preciso y certero, pero reafirmó la necesidad de castración y por ello me dio un turno de cirugía para la fecha 13/07/2020 a las 9:20hs.

9. El 13/07/2020 llevé a Lola a la hora pactada: 9.20hs, pero a las 11:50 hs de ese mismo recibí un llamado de la Méd. Vet. Díaz diciéndome que la cirugía “había salido mal” y que debía ir urgente, que Lola estaba muriendo.

10. Al llegar a la veterinaria, Lola estaba inconsciente, no me reconoció en lo absoluto y estaba tendida sobre una mesa, con un sachet de suero vacío. Agonizante. Le hablaba, la llamaba por su nombre y no reaccionaba en lo absoluto.

11. Cuando pregunté qué había pasado me explicó la Méd. Vet. Díaz que debido a una supuesta “malformación: el riñón estaba debajo del útero”, que al querer seccionar el ovario se despegó, “se le salió” (sic) el riñón incluido en esa extracción – me hizo un dibujo explicativo sobre la ubicación– y que por eso le cortó la arteria renal, lo que llevo a que Lola perdiera muchísima sangre generando una severa descompensación.

12. En pleno relato, yo advertí que el sachet de suero se había terminado, le pedí que le pusiera suero nuevo, que estaba vacío el que Lola tenía canalizado y le indicó a su colaboradora Med. Vet. Mayra Calabozo M.P. 4352 que le pusiera uno nuevo, quien así lo hizo.

13. En el momento en que vi a Lola agonizante le pedí que hiciera algo, que la transfundiera si lo que estaba diciendo era que Lola había perdido mucha sangre, le dije, le señalé que mi perrita se moría, que le costaba respirar: pero contestó que no tenía en su quirófano ni oxígeno ni los insumos correspondientes para transfundir sangre (“no tengo bolsa” sic).

14. Le rogué, le pedí por favor, hiciera algo por Lola para salvarla, insistió en que no tenía sangre para transfundir en su veterinaria le dije que yo se la conseguía, aconsejó entonces traer un canino donante, fui rápidamente a buscar el perro de mi vecina Marisa Rebesch, en el ínterin la Méd. Vet. María Belén Díaz salió a buscar a una veterinaria cercana, a lo de

“un colega” una bolsa de sangre y agujas.

15. Una vez con mi vecina (Marisa Rebesch) quien acudió conmigo para colaborar en ese momento, presencié de principio a fin todo este suceso de situaciones: al regresar la Med. Vet. Díaz y pretender transfundir a Lola la bolsa y manguera que había conseguido prestada no funcionaba, la sangre no bajaba, por eso la Dra. Díaz hizo una serie de manipulaciones manuales con una tijera de uso quirúrgico (estiraba la manguera con la tijera) para que bajase y no logró que funcionara, pues era una bolsa muy grande.

16. Cabe destacar que la bolsa y mangueras no estaban ni esterilizada ni en condiciones para poder funcionar, pues la había traído en la mano y jamás usó guantes.

17. Este despliegue de medidas a último momento no mejoró en lo absoluto la situación crítica de Lola, por eso la Med. Vet. Díaz procedió a hacer reanimación insertando una bomba manual para darle aire a mi perrita, pero no hubo caso.

18. Todo esto fue en vano. Lola murió cerca de las 14:30hs. Al retirarme con mi perra en brazos le pedí me diera copia de la historia médica de Lola, pero se negó rotundamente a hacerlo.

19. La Med. Vet. Díaz tampoco quiso darme copia del consentimiento informado que había suscripto más temprano esa mañana, al dejar a Lola internada me dijo: “Lola no es un humano”! (sic).

20. Más tarde, ese mismo día continué pidiendo copia de la historia clínica vía telefónica, pedí me pasara su CBU para abonar el saldo de sus honorarios profesionales y también le pedía explicaciones sobre lo sucedido, no podía salir del asombro, finalmente me bloqueó del whatsapp.

21. La reticencia y vulneración a mis derechos por parte de la Med. Vet. Maria Belén Díaz se hizo tan evidente que luego de varios intercambios por whatsapp, con fecha 23/07/2020 la Méd. Vet. Díaz me remitió Carta Documento CD76199785 en donde textualmente expresa: “...Asimismo, si eventualmente el Colegio Veterinario de esta Ciudad requiera copia de la

historia clínica de su mascota, será puesta a disposición de este último”. Es incomprensible esta manifestación, pues no la había relevado de guardar el secreto profesional a la Dra. Díaz.

22. Acudí al Colegio de Veterinarios de la Provincia de Córdoba con fecha 17/07/2020 para expresar no solo mi mala experiencia con esta profesional atento a su falta de trato digno y ético hacia mi persona y de Lola, sino también para pedirles a ellos por su intermedio avalasen el pedido de copia de la historia clínica, e insólitamente confirmó esta institución la postura de esta profesional médica veterinaria – Dra. Díaz – quien se había negado reiterada, agresiva y acreditadamente.

23. El Consejo Directivo del Colegio de Veterinarios de esta Provincia con fecha 12/08/2020 me respondió vía correo electrónico: “De nuestra mayor consideración: Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a fin de interiorizarlo sobre las actuaciones llevadas a cabo, le hacemos saber con relación a vuestra denuncia efectuada en contra de la Dra. DIAZ, MARIA BELÉN m.p. 2638 que esta Institución ha efectuado las investigaciones correspondientes, de los cuales resulta que no existen aspectos éticos profesionales que prima facie aparezcan violados por el profesional, razones por las que con los elementos colectados hasta el presente, la denuncia ha sido desestimada por decisión de Consejo Directivo. Sin otro particular, saludamos a Usted atentamente. Consejo Directivo. C.M.V.P.C.”.

24. Remarco S.S. que no podemos soslayar que la situación desencadenante del fallecimiento de “Lola” se contextualiza físicamente en el quirófano de la Veterinaria Hakuna Matata sita en el lugar indicado ab initio, el cual conocí por esta urgencia, pero al hacerlo advertí que estaba repleto de cajas de cartón, objetos de diversos materiales encimados por los estantes al costado, escaso de iluminación. La sala quirúrgica, se encontraba completamente descuidada en limpieza, oscura y desprovista de los elementos e insumos indispensables para una cirugía, máxime si tal como fue éste cuadro clínico poco claro ab initio, en donde los diagnósticos fueron variando hasta llegar a la indicación de castración en el cual la

ovariohisterectomía implica la extirpación del aparato reproductor, y máxime aún si en ese mismo acto se extirpa otro órgano – riñón - cuya irrigación sanguínea es absolutamente mayor a la de una cirugía común.

25. Manifiesto que procedí a denunciar con fecha 21/07/2020 por ante la Municipalidad de Córdoba el incumplimiento de normas sanitarias del nosocomio veterinario especialmente de la sala quirúrgica y con fecha 15/07/2020 por ante la Dirección de Defensa del Consumidor –copias escaneadas de dichas presentaciones y de la documental mencionada acompaño en archivo adjunto declarando la concordancia y vigencia de las mismas hasta el momento de su efectiva compulsa según lo dispuesto por A Acuerdo Reglamentario N° 1622 serie “A” del 12/04/2020-.

26. Toda esa serie de eventos desafortunados desde el 01/07/2020 sin un tratamiento adecuado, hicieron que hasta hoy llore a mi perrita Lola, a quien consideraba mi familia, falleció – tal como será probado en estos autos- a causa de la mala praxis profesional de la Med. Veterinaria María Belén Díaz.

27. Por ello es que, atento los hechos relatados y la prueba de los daños sufridos conforme surja de las pruebas que oportunamente fueren rendidas, solicito se condene a la Med. Veterinaria María Belén Díaz al resarcimiento de los rubros que se detallan más adelante, con especial consideración a sus estudios médicos y honores particulares pre y post tratamiento médico y quirúrgicos como así también los años en el ejercicio de la referida especialidad que ostenta el/la demandado.

28. Cabe destacar como dato de extrema relevancia que el “Consentimiento Informado” que suscribí esa mañana del 13/07/2020 en la que dejé a Lola a los fines de la castración y que la propia Med. Veterinaria Ma. Belén Díaz me hiciera suscribir sin haberme informado detalladamente el procedimiento ni el diagnóstico definitivo ni los riesgos, muy lejos se encuentra ser el ACTO CLINICO previsto por la ley (art...) que debiera ser. Prueba de ello configura la fecha con la cual ha sido completado este escueto formulario preimpreso

intitulado “AUTORIZACION DE CIRUGIA”, cuya fecha consignada de puño y letra de la profesional actuante ya citada es 14/07/2020, mi nombre no está completo, la edad de Lola no era de 6 años en ese momento, y en concreto solo autorice a realizar la intervención quirúrgica consistente en “OVH” que necesitaba Lola para evitar la “piometra”.

29. Falta de diagnóstico real de la enfermedad de Lola. La mala praxis en la atención de Lola surge ab initio, debido no solo al obrar errático inicial en tanto el tratamiento llevado a cabo según el relato previo de los hechos incurrió en el sucesivo cambio de antibióticos atento a no haber encuadrado el caso clínico con certeza ab initio. Lo que conllevó incluso al malestar permanente y prolongado de Lola durante más de una semana.

30. Aquel diagnóstico inicial presuntivo e hipotético, significó la realización de análisis bioquímicos en laboratorio recién con fecha 07/07/2020 (7 días después de la primera consulta) y la falta de realización de estudios complementarios que determinasen la certeza en el diagnóstico y por ende la nula factibilidad de sobrevida de Lola en tanto el obrar médico en el acto quirúrgico durante y con posterioridad a la cirugía en tanto el actuar negligente y omisivo de la médica veterinaria María Belén Díaz significaron la muerte de mi perrita.

IV. PRUEBA ANTICIPADA Atento a) la conducta desplegada por la demanda Dra. Díaz a partir del día del hecho— en cuanto a la reticencia de entrega de copia de historia clínica, epicrisis o constancia alguna relativa a lo acontecido aquel 13/07/2020, b) la relevancia que significaba esta prueba, c) el peligro y situación de riesgo en que podría encontrarse a partir del traslado de la demanda, se llevó a cabo el secuestro de la historia clínica en la Clínica Veterinaria Hakuna Matata sita en Av. Armada Argentina N° 209 de B° Las Flores de esta Ciudad de Córdoba.

Aun habiendo tenido lugar el diligenciamiento del secuestro por oficial público, pudo secuestrarse la “autorización de cirugía” ya que la hoy demandada Dra. Díaz dejó la historia clínica en el Colegio de Veterinarios, institución que con fecha 02/02/2021 procedió

a acompañar “copia fiel” de la documental obrante en su poder.

Dejo constancia que producto del secuestro ordenado en los presentes se encuentra reservado en Secretaria de vtro. Tribunal según Certificado de fecha 23/12/2020 (bibliorato ordinario año 2020) documental consistente en: oficio de secuestro diligenciado por la Oficial de Justicia Ab. Roxana Suarez, en un total de 8 fs. útiles en donde obran estudios de laboratorio y autorización de cirugía de Lola.

La historia clínica efectuada en la Clínica Veterinaria Hakuna Matata adolece de los requisitos mínimos indispensables para ser una historia clínica profesionalmente bien elaborada: solo obra un diagnostico presuntivo, no hay descripción completa del cuadro clínico que presentaba Lola, se evidencia una exploración física deficiente, solo se describen signos en algunos días de control que no aportan elementos para dilucidar clara y precisamente el estado y evolución de Lola» (sic).

Seguidamente se expidió sobre los presupuestos de la responsabilidad del siguiente modo:

a) **Antijuridicidad:** *«Este presupuesto que consiste en la infracción al deber general de no dañar a nadie sin que medie justificación... No se encuentra presente en el caso justificación alguna que pueda soslayar la responsabilidad profesional de la médica veterinaria titular de la Clínica Veterinaria Hakuna Matata el día de los hechos (Dra. Díaz) -y de quien ostenta la titularidad del establecimiento al día de la fecha de hoy (Dr. Cravero) – donde se llevó a cabo la cirugía, ambos demandados- en tanto no se encuentran presente ninguna de las causales que eximen del deber de responder según lo estipulado en nuestro CCyC.*

Cabe destacar que el Consentimiento Informado invocado por la propia Dra. Díaz en oportunidad del envío mediante misiva formal a la actora Maria Sol Marrero con fecha (CD 076199785) 23/07/2020 textualmente expresa: “Por otro lado le INFORMO que, tal como refleja el consentimiento informado para cirugía y suscripto de su puño y letra, previamente a Ud. explicado; el mismo refleja un resumen de lo que se trabajó oportunamente en la cirugía producto del cuadro que presentara su mascota al ingresar a la veterinaria, infección

uterina (piometra)...”

Es de remarcar que dicho consentimiento informado, del cual no se brindó copia ni en la realidad de los hechos fue explicado, tampoco coincide – no es concordante - con el momento en el que fue firmado por mí, por lo cual adolece de una defectuosidad formal manifiestamente grave, pues ostenta una fecha posterior al día en el que tuvo lugar la cirugía de Lola.

El documento invocado por la hoy demandada en su misiva “autorización de cirugía” (y posteriormente secuestrado judicialmente) contiene como fecha de realización el 14/07/2020 y no el día 13/07/2020 que fue el día de la cirugía fatal, ha sido confeccionado como un formulario preimpreso en el que solamente se expresa una “Autorización para cirugía”...

Desconozco si aquella autorización de cirugía estaba en blanco cuando lo suscribí, si ya estaba erróneamente confeccionado antes de que yo lo firmara, o si fue adulterado colocándose una fecha con posterioridad. De ser esta última opción, resulta ser el actuar profesional gravemente reprochable en términos de culpa profesional, pues todos los indicios nos llevan a un actuar negligente.

No obstante esta conducta, jamás se me explicó el contenido del mismo. Solo se me pidió inquisitivamente la firma del documento, a lo cual accedí al dejar a Lola esa mañana temprano para ser intervenida ese mismo día: 13/07/20.

El documento en cuestión cita como antecedentes clínicos: INFECCION UTERINA (PIOMETRA) y según el mismo, la práctica que autoricé a realizar según dicho formulario preimpreso es una “OVH” iniciales o palabra que desconozco en lo absoluto, que no se me explicó y que según la jerga veterinaria con posterioridad me enteré que eso significa OVARIOHISTERECTOMIA.

Quiero expresar que es lógico asumir los riesgos quirúrgicos y anestésicos, pero esa autorización lejos está presumir autorizar el corte de una arteria principal en el paciente,

que en el caso fue Lola o de la extirpación de un órgano (riñón) frente a una supuesta malformación como me explicó la Dra. Díaz.

Estos actos quirúrgicos precisos (extirpación de un riñón y corte de arteria renal) fueron reconocidos expresamente por la Dra. Maria Belén Díaz en los chats que intercambiamos el día de la cirugía y el día posterior tal como acreditaré.

Del texto de la CD cursada a mi persona por parte de la Dra. Díaz, surge la contradicción de expresar que yo suscribí algo (con posterioridad a la cirugía), pues en términos temporales habla de un “resumen de lo que se trabajó”, cuando en realidad yo suscribí la “autorización de cirugía” previo a la misma, es decir el día 13/07/2020 por la mañana, lejos puede estar de relatar lo que sucedió en la cirugía, no es fácticamente posible, no se procedió a una “OVH”, en los hechos se cortó una arteria renal y se extirpó un riñón...

En esta línea, la expresión formulada por la Med. Vet. Díaz en la CD mencionada no concuerda con sus propias expresiones en ocasión de la conversación de whatsapp mantenida conmigo (o con Maria Sol Marrero) una vez acontecido el hecho definitivo y originante del presente reclamo: Belén Veterinaria “Lo que dio fiebre sabes q fue el útero”...”y el riñón estaba abajo del ovario”, “están conectados por eso te dije que la infección puede afectar a la parte renal x eso también en la sangre sale caldo renal” ...“al extirpar un riñón su organismo tiene q compensar la pérdida y ella no lo aguanto”... (Se procede a transcribir la conversación completa surgida del acta de constatación notarial en el capítulo destinado al ofrecimiento de la prueba documental).

Con esto quiero resaltar SS la contrariedad de los propios dichos de la profesional actuante, en tanto afirma haber intervenido quirúrgicamente a Lola a los fines de evitar un desenlace fatal por infección intrauterina, pero cuyo desenlace fatal termina aconteciendo a causa de la extirpación de un riñón que supuestamente estaba ubicado -en virtud de una malformación- que no surgió de la ecografía llevada a cabo por la misma profesional actuante previamente, de hecho nada surge de la “historia clínica” acompañada.

Tampoco surge de la historia clínica que la Dra. Díaz depositó en el Colegio Veterinario que haya tenido lugar dicha realidad quirúrgica, ni la cirugía efectivamente desarrollada en términos de Ovariohisterectomía, pues nada dice en el relato documental respectivo.

Otro elemento indiciario más de culpa profesional en tanto la deficiente confección de la Historia Clínica nada más y nada menos que para el desenlace fatal quirúrgico permiten presumir un actuar reiteradamente negligente dado que se encuentran todos estos actos médicos directamente relacionados con la mala praxis profesional atribuida a la demandada principal» (sic).

b) Factor de atribución: *«Establece el art. 1768 del CCyC, “La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la Sección 7ª de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en el responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el art. 1757”.*

En el caso, la Dra. Díaz diagnosticó Piometra (infección en el útero), más el comienzo del tratamiento se enfocó originalmente en un cuadro gripal, cambiando la medicación en virtud de la reacción de Lola. La infección se acreditó recién con el laboratorio días después de la primera consulta en donde la paciente ya acusaba estado febril.

El laboratorio, fue solicitado omitiendo el pedido de “urea”, el cual hubiera sido determinante a los fines de evaluar un eventual mal funcionamiento renal...

El medico se obliga a cumplir una serie de deberes, principales y accesorios, dirigidos precisamente a ese propósito o finalidad que es que el enfermo recupere la salud, supere la dolencia que le aflige sea clínica o quirúrgicamente...

Es necesario recordar y traer a este acápite el derrotero procesal que esta parte debió llevar adelante atento a la reiterada reticencia de la profesional -Dra. Díaz- en tanto se negó

violentamente de manera verbal a dar copia de historia clínica, y formalmente en su misiva ya relacionada determino que el depositario de la misma era el Colegio Médico Veterinario, desconociendo notoriamente las obligaciones profesionales que le incumben como tal, pues el resguardo de la documentación profesional le compete a ella exclusivamente.

Las reglas de la Ética para médicos veterinarios según Ley 6515 de la Provincia de Córdoba, Estatuto y Código de Ética Actual, DEBERES PARA CON LOS CLIENTES establece en el Artículo 4º: “Son deberes de los Médicos Veterinarios para con sus clientes: a) Evitar todo acto que pueda obrar desfavorablemente en el ánimo del cliente y que pueda contribuir al desprestigio de la profesión, limitando la actividad profesional a lo estrictamente indispensable y compatible con las necesidades de la misión a cumplir.”

Lejos está de este deber la conducta desplegada por la Dra. Maria Belén Díaz en tanto su actuar reticente al pedido de quien había experimentado una pérdida y el bloqueo telefónico posterior. Es decir, procedió al rechazo a mantener cualquier tipo de comunicación.

Dicha normativa se corresponde idénticamente con la Ley Nacional Ley Nro. 14.072 Dcto. P. E. 8561/67 del Código de Ética Profesional para Médicos Veterinarios ya que configura una transcripción idéntica.

En este sentido cabe remarcar que luego de haber extirpado el riñón y cortado la arteria -tal como reconoció la Dra. Díaz -, sus instalaciones no contenían los insumos básicos para sobrellevar un post operatorio crítico tal como el que experimento Lola, pues no había sangre para transfundir, oxígeno, luz adecuada ni nada que pudiese permitir mejorar -al menos- el estado crítico de Lola.

Tal como surge de lo relatado en los puntos 21 y 25 de los hechos, procedí a explicar por ante el Colegio Médico Veterinario de esta Provincia y por ante la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba la deficiencia de las instalaciones de la Clínica Veterinaria Hakuna Matata, de manera tal que desde un primer momento quise dejar de manifiesto, acreditado el

estado del quirófano de la Clínica Hakuna Matata.

Asimismo, existen testimonios que avalan lo afirmado por Maria Sol Marrero y serán producidos en la etapa procesal oportuna.

De la “copia fiel” de Historia Clínica acompañada por el responsable del Colegio Médico Veterinario surge que la misma si bien contiene relación de las visitas que realizaban a la Veterinaria desde el año 2014, sucesiva y anualmente hasta llegar a la fecha relativa al evento que aquí nos convoca: comienza el 02/07/2020 en donde documenta la Dra. Díaz – con letra poco legible – el cuadro clínico originalmente manifestando temperatura (39°), tos, reflejo. Con posterioridad sin saber si corresponde a la misma fecha se relaciona Dexa, Bactoprofen, Castrar. 07/07/2020. Luego, indica continuación del cuadro, análisis de sangre y ecografía. Luego, resultados (sin indicar cuales fueron), toxicidad, palabras ilegibles Ecografía Útero Indica CX. A continuación, 13/07/20 – Cirugía.

Amén de lo que a nuestro parecer pueda resultar poco legible, la confección de la presente historia clínica no resulta clara en principio atento a que las fechas comienzan desde el inicio de la misma (año 2014) consignando la fecha al comienzo de cada visita, mientras que luego del 02/07/2020 – es decir a partir del 07/07/20 la fecha es colocada con posterioridad.

El seguimiento que se hace del cuadro clínico de lola no arroja en ningún momento el motivo desencadenante del deceso de Lola. Nada se dice al respecto, y tampoco se advierten los resultados de los estudios que se realizaron» (sic).

c) Relación de causalidad: *«La determinación de la relación de causalidad entre el hecho generador y la responsabilidad aquí endilgada surge a que el deceso de Lola tuvo como única causal el actuar profesional defectuoso de la Medica Veterinaria María Belén Díaz en el ámbito de la Clínica Veterinaria Hakuna Matata.*

Oportuno resulta relacionar lo surgido de la conversación mantenida vía Whatsapp entre esta y la actora con fecha lo cual surge de la Escritura Nro. 28 Secc. B de fecha

13/05/2022 ante la Escribana María Paola Marengo titular del registro Nro. 255 de esta Ciudad de Córdoba de la cual surge: “la compareciente me requiere constate que en su teléfono celular marca Samsung.... 13/7/2020 16.18: Sol: Belén,... pásame cuanto te debo... y algún CBU: 16.19: Sol: Así te lo transfiero; 16.42: Belén Veterinaria: Si no te hagas problema después te lo paso.. a mí no me importa el \$ lamento lo q paso yo opero para salvar vidas no para q se mueran pero uno nunca sabe con lo q se va encontrar cuando abre un paciente, me vine a casa un rato porque realmente me puso muy mal lo q paso. Después te paso tot. 16.46 Sol: Si estamos destruidas. 16.46: Sol: Mi cabeza no para de pensar; 16.46 Sol Quizás con un tratamiento, 13/7/20 16.47: Sol: pienso que fue mucho castrar no se no encuentro camla 16.48. Belén Veterinaria: Hace 10 años que opero y creo que esta fue la 2da. Que tuvo este problema pero como te digo no había forma de saberlo sino la abríamos, te lo seguro q si sabía lo q iba a pasar nunca te hubiera recomendado una castración 16.51 Belén Veterinaria: Ella estaba perfecta salvo su infección que era muy alta y si seguíamos esperando hubiera sido peor, perras han entrado en peor estado sin expectativas de vida y sin embargo han salido esto no es exacto es la naturaleza es lo único q puedo decirte, yo a pesar de estar mal estoy tranquila x hice lo q tenia q hacer. No sé qué más decirte Sol solo q lamento igual q ustedes la pérdida xq soy muy afecta con mis pacientes y para mí no es uno más 16.53: Sol me queda el pensar si q hice si la hubiera tratado y no castrado 16.53 Sol No puedo dejar de llorar y penase. Belén Veterinaria: Yo te aseguro q esto iba a ser peor, por eso lo hicimos vos hiciste lo correcto, 17.02 Sol: haber discúlpame... si es q era lo q e dio fiebre 17.02 Sol. No logro entender 17.02 Sol: el útero o el riñón) 17.02: Belén Veterinaria: Sol cuando quieras te espero por la veterinaria 17.02 Belén Veterinaria: Las dos cosas te explique No hablo más por mensaje discúlpame Lo que dio fiebre sabes que fue el útero Y el riñón estaba abajo del ovario 17.04 Belén Veterinaria: Están conectados por eso te dije q la infección puede afectar a la parte renal x eso también en la sangre sale caldo renal; 17.06 Belén Veterinaria: Al extirpar un riñón su organismo tiene q compensar la pérdida y ella no

lo aguantó.

De esta transcripción que será acompañada a los presentes y cuya oportuna pericia informática respaldará su existencia, surge que el actuar quirúrgico de la Dra. María Belén Díaz significó finalmente la extracción de otro órgano: el riñón por una supuesta atribuida malformación (que no fue médicamente documentada pese haber realizado ecografía previa) surge que riñón y útero estaban conectados y que aduce haber descubierto “al abrir” a Lola.

Sin embargo, ni de la historia clínica de Lola en cuanto a su normal y saludable desarrollo fisiológico desde su nacimiento, constatado por la misma profesional interviniente ni de la ecografía que realizó en los días previos a la cirugía surgió la malformación descubierta en la cirugía en cuestión.

El deber del médico es el funcionamiento adecuado de la aparatología que usa para servirse de la misma, efectuar los diagnósticos precisos y certeros que conduzcan a una actuar profesional acorde a su diligente ejercicio profesional.

Este hecho nos brinda el adecuado nexo causal entre el hecho generador de la responsabilidad profesional y el fallecimiento de Lola» (sic).

d) Daño: « Según el art. 1737 del CCyC establece: “Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”.

El daño resarcible según estipula el art. 1739 determina los requisitos para la viabilidad del reclamo del daño indemnizable, los cuales se vinculan con la existencia directa o indirecta, actual o futura, certeza y subsistencia...

Podemos remitirnos al antropocentrismo de nuestro CCyC en donde los animales son considerados cosas muebles, o podemos aggiornarnos y remitirnos a la realidad familiar de María Sol, Norma Sofía Barbero (su mamá) y Lola, en la que Lola era una integrante más de su familia...

En el caso que nos ocupa, de la muerte de Lola resulta:

a) directo en tanto convivía conmigo, Maria Sol Marrero y Norma Sofía Barbero (mi madre y cuidadora durante las hs. en las que yo no estaba en casa), siendo parte de la familia.

Maria Sol consideraba a Lola “su hija” según surgen de las constancias notariales agregadas en el presente escrito y de los testimonios que serán receptados, asimismo Norma su mamá de profesión jubilada convivía las 24hs con Lola en la casa,

b) actual en cuanto hasta el día de la fecha las actoras continúan sufriendo su ausencia, de hecho en las redes sociales se recuerda cada aniversario del fallecimiento de Lola;

c) cierto: es obvia la situación existente aun al día de la fecha en tanto la ausencia intempestiva de Lola ha traído una realidad muy diferente a la que las actoras tenían planeado para ellas de manera conjunta;

d) subsistente, en reiteración a las consideraciones vertidas, la ausencia de Lola aún resulta un doloroso transitar para su familia, Lola esta sepultada en el Jardín trasero de la casa familiar en donde se sembraron flores para adornar su lugar.

El daño resarcible en este caso, surge directamente del actuar negligente de la hoy demandada, en primer término el perjuicio sufrido a raíz de la muerte de Lola cuya apreciación pecuniaria asciende al monto del precio de un perro caniche.

Daño Moral: en este acápite, en primer término haremos una relación de lo que se considera un animal no humano de compañía como lo era Lola, pues su situación ronda las consideraciones jurisprudenciales en esta materia y lo que prestigiosa doctrina reafirma en el mismo sentido.

La ciencia se ha expresado en este sentido y por ello serán acompañados los extremos que justifican el pedido de indemnización en el presente rubro de daño moral.

En la etapa procesal oportuna se producirán las pruebas periciales respectivas a los fines de acreditar la dolencia emocional que la actora padece incluso al día de la fecha» (sic).

Peticiona, en definitiva, la indemnización de los siguientes daños: a) Costo de adquisición de

una perra hembra raza caniche toy blanca (\$ 40.000,00); b) Daño moral (\$ 200.000); c) Gastos médicos por atención veterinaria y estudios médicos (\$ 3.900) y d) Gastos por costas en virtud de prueba anticipada (\$ 18.316).

Finalmente ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

2.- Por decreto de fecha 16/02/2023 se acumulan a estas actuaciones los autos **MARRERO, MARIA SOL C/ DIAZ, MARIA BELÉN - PRUEBA ANTICIPADA** (Expte. N° 9507893).

3.- Con fecha 31/03/2023 la parte actora readecúa la demanda, expresando que la acción se dirige únicamente en contra de María Belén Díaz (DNI 27.655.581) como única dueña oportunamente del local comercial y clínica veterinaria Hakuna Matata, configurando éste un nombre de fantasía.

Asimismo, en relación a la prueba confesional e informativa ofrecida en el escrito de demanda, se solicita se tenga por no solicitada la requerida únicamente en relación al nuevo titular (Sr. Cravero) del local comercial y clínica veterinaria Hakuna Matata atento a la readecuación aquí formulada.

4.- Por decreto de fecha 16/02/2023 se acumulan a estas actuaciones los autos **MARRERO, MARIA SOL C/ DIAZ, MARIA BELÉN - EMBARGO PREVENTIVO** (Expte. N° 11544269).

5.- Mediante proveído de fecha 04/05/2023 se imprime trámite de ley.

6.- Con fecha 22/05/2023 comparece la Sra. María Belén Díaz, con el patrocinio letrado de la Dra. María Belén Cura Carosini y evacua el traslado de la demanda.

En primer término, efectúa una negativa genérica y específica de los hechos narrados por la actora.

Luego, expresa su versión de los hechos como sigue: *«Que el día 02/07/2020, la paciente acude a consulta por decaimiento y tos, en la cual se constata leve aumento de temperatura (39°) y reflejo tusígeno positivo, a la auscultación pulmonar sin particularidades, se medica con inyectables (penicilina strepto y dexametasona) y se indica bactroprofen 1/2 comp. c/12*

hs. de 7 a 10 días, conforme control y evolución de la paciente.

A los días, se comunica vía telefónica, la Sra. Marrero, expresando que la paciente no toleraba la medicación; ante lo expuesto se decide cambiar de antibiótico (a Enrofloxacin) y, se le indica a la propietaria que me comunique la evolución de la paciente. La Sra. Marrero, al no notar mejoría, acude con su mascota, al control presencial en la veterinaria. Luego, del examen clínico de la paciente, decido extraerle sangre; previa explicación e información de que al ser una paciente hembra sin castrar y por su edad, necesitan hacer análisis y estudios complementarios para derivar en un diagnóstico.

En este estado las cosas, el día 10/07/2020, se realizó la ecografía, en la cual se observó colecta uterina en ambos cuernos uterinos, no se visualizaron ni ovario ni riñón izquierdo, resto de órganos sin particularidades.

Luego, de tener los resultados de sangre, en donde se observa aumento de leucocitos y presencia de neutrófilos tóxicos, sumado al resultado de la ecografía; se explica el cuadro sintomatológico y semiológico que presentaba Lola; poniendo, particular énfasis, que la única solución posible, a los fines de evitar una septicemia grave y generalizada en el organismo de Lola, era mediante la castración (extirpación de útero y ovarios).

Su respuesta a esto fue que “lo iba a pensar”, ya que no estaba decidida a realizarla, pese a mi insistencia y explicarle los riesgos de no ser llevada cabo dicha práctica.

Pasados unos días, se comunica vía telefónica para solicitar turno, le vuelvo a explicar el cuadro y le doy el turno lo antes posible, dada la situación particular del momento (emergencia sanitaria, COVID-19), donde la demanda de urgencias y atención médica era muy alta.

Finalmente, el día 13/07/2020, alrededor de las 9.20 hs. llega la propietaria con la paciente, se procede a la firma de la autorización de cirugía, previa explicación, nuevamente del cuadro y el acto quirúrgico al cual iba a ser sometida y sus riesgos.

Consentido ello por la propietaria, se procede a realizar en la paciente, canalización y

fluidoterapia, para luego colocar la premedicación (xilacina, acepromacina y ketamina) con las dosis de acuerdo al peso del paciente.

Posterior a ello, se realiza tricotomía y asepsia de la zona quirúrgica, se colocan los paños quirúrgicos y se incide por línea media, se exponen los cuernos uterinos, se liga el ovario derecho sin dificultad, luego al tratar de exponer el cuerpo uterino izquierdo, como consecuencia del cuadro infeccioso antes mencionado y coincidente con el resultado laboratorio y ecografía; se observan adherencias, lo que dificulta la ligadura de la arteria ovárica, para su mayor visualización se procede a la utilización de diferentes tipos de separadores para ampliar el campo operatorio. Y para no forzar el útero, ya que este se encontraba en condiciones friables, durante dicha maniobra se observa adherencias en la zona perirrenal, en intento de liberar el ovario de dicha adherencia empieza una hemorragia profusa, impidiendo una buena visión del campo quirúrgico, la cual disminuye al ligar la arteria renal. Una vez resuelta la hemorragia, se decide, dadas las adherencias antes mencionadas, realizar una nefrectomía (extirpación del riñón). Inmediatamente, se realiza una profusa fluidoterapia para evitar un shock hipovolémico.

Posteriormente, se continúa con la técnica de ovariohisterectomía, ligando el útero, realizando una transficción, limpieza de cavidad y de la zona, luego se procede a suturar músculo con puntos en X, subcutáneo y piel.

Al terminar, se le comunica a la propietaria la complicación intraquirúrgica que había acontecido y, por la pérdida de sangre, se recomienda una transfusión de sangre y, conforme los usos y costumbres de las veterinarias; se le solicita, al propietario un paciente donante con los requisitos para esta práctica, ya que no existía banco de sangre dada la situación del momento (emergencia sanitaria, pandemia).

Acto seguido, se realiza la transfusión, con el material acorde, el cual viene esterilizado y cerrado al vacío. Momentos estos en que, se estaba realizando la transfusión, la paciente entra en paro cardiorrespiratorio; para lo cual, se realizan las maniobras de reanimación, se

coloca traqueo tubo y bolsa ambu, pese a todo lo realizado la paciente lamentablemente fallece, estando la propietaria presente.

Luego, se le explica a la propietaria todo lo sucedido, pero dada la situación emocional, en la cual se encontraba, la información no es bien receptada y decide llevar el cuerpo de la mascota.

Al pasar las horas, la propietaria solicita explicación vía telefónica (WhatsApp), creyendo que esta vía no es la pertinente para hablar; le solicito, que acuda a la veterinaria y al recibir agravios e improperios hacia mi persona y profesional, decido bloquear su contacto. Posterior a ello, al pasar los días recibo vía redes sociales (Instagram, y por correo electrónico) insultos y difamación hacia mi persona y como profesional.

Relatados aquí, la realidad de los hechos, agrego, que Lola, era mi paciente desde cachorra y su pérdida resultó una tristeza para mí también.

Logré, pese al cuadro y diagnóstico que presentaba Lola, que saliera con vida de la cirugía y agoté todos los medios posibles para salvarle la vida. Nunca mi obrar profesional y personal fue negligente y con ausencia de conocimiento de lo que estaba haciendo.

La práctica de la medicina, y en caso medicina veterinaria, no es una ciencia exacta y existen variaciones orgánicas, individuales de cada paciente, que impiden garantizar que se obtenga muchas veces el resultado esperado.

Cabe poner de resalto, esta situación, me ocasionó problemas emocionales y laborales; ya que no pude realizar más cirugías, llegando a la situación extrema de no poder mantener más mi veterinaria, siendo que era mi sustento económico, y al día de hoy tengo secuelas de este episodio»(sic).

A continuación opone excepción de falta de acción por falta de legitimación pasiva e inexistencia de responsabilidad profesional, en los siguientes términos: «Es de menester destacar que el hecho en que se funda la demanda es la contratación de los servicios profesionales de médico veterinario, y, por tanto, no quedan dudas, que corresponde

subsumir por un lado, la relación jurídica habida entre las partes en los arts. 1251, 1252, 1278 denominan locación de servicios y la responsabilidad, del “hacer” ese servicio por parte de una profesional liberal (médica veterinaria), en el art. 1768 del mismo cuerpo legal; en ambos supuestos, los mismos artículos, remiten a lo reglamentado la norma a los art. 773 y 774 del CCCN.

Dicho esto, dejo planteada la excepción FALTA DE ACCIÓN (SINE ACTIO AGIT), para que la misma sea resuelta por SS al momento de sentenciar.

Que, tal como surge de lo relatado en el acápite de realidad de los hechos, esta parte obró conforme la práctica, la pericia y la diligencia que requería el cuadro clínico presentado en el quirófano. Toda la atención a la paciente, fue con el fin de evitar un mal mayor, pese a los riesgos que se pueden suscitar en una cirugía.

Así, de la relación existente entre la propietaria de la paciente y su médica veterinaria, engasta en la figura del contrato de locación de servicios, que comprende una obligación de medios y no de resultado.

En este distingo, entre obligaciones de medios y de resultados, radica la diversidad existente, ni más ni menos que en el factor de atribución, hecho que determina cuáles son las eximentes de responsabilidad a utilizar en cada caso.

En las primeras, el criterio legal de imputación es la culpa; y en las restantes, el factor de atribución es objetivo, de modo que el responsable se libera demostrando la causa ajena, salvo disposición legal en contrario (arts. 1722 y 1723 CC yC).

Tal como refiere el art. 774 del CCCN, “(...) la prestación de un servicio puede consistir en: a) la realización de una actividad con la diligencia apropiada independientemente de su éxito. Tal lo que sucede con las cláusulas que comprometen a los buenos oficios o a aplicar los mejores esfuerzos (...)” En este caso, el deudor asume el cumplimiento de una obligación de medios, pues lo que ha asumido es un compromiso de diligencia que solo tiende a la consecución del resultado final. El incumplimiento se verifica cuando el deudor omite prestar

esa conducta calificada.

La prestación de un servicio puede consistir en la realización de una actividad con la diligencia apropiada independientemente de su éxito.

También, el art. 1768 CCCN, dispone que la responsabilidad del profesional liberal es subjetiva, salvo que haya comprometido un resultado concreto.

Ahora bien, para determinar cuándo nos encontramos ante una obligación de fines o de medios debemos recurrir a las pautas brindadas por las normas mencionadas en último término. Si lo “convenido por las partes” y las “circunstancias de la obligación” permiten advertir que se comprometió un resultado determinado, la diligencia del deudor será irrelevante a los fines de configurar el incumplimiento (art. 1723 CC yC).

Por el contrario, como en la relación jurídica de autos, en las obligaciones de hacer deberá valorarse si el deudor se comprometió a desarrollar cierta actividad (cirugía), con la diligencia apropiada (art. 774, inc. a, CCCN), supuesto en el cual nos encontramos ante una obligación de medios.

En este sentido, es preciso tener en cuenta que el art. 1768 del CCCN, la norma en comentario no se refiere a la carga de la prueba de la culpa del deudor, sino a cuál es el factor de atribución aplicable en el caso.

Para la carga de la prueba rige el principio del art. 1734 CCCN, el acreedor (Sra. Marrero) deberá probar el incumplimiento, lo que en la obligación de medios equivale a probar la culpa; todo lo cual, SS, no surge del relato de la demanda, ni aún al mencionar los presupuestos de responsabilidad.

Retomando, el postulado de responsabilidad profesional y remitiéndose al art. 1724; se entiende, que son factores subjetivos de atribución, la culpa y el dolo.

Por culpa, la calificada doctrina entiende que, consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar; comprende las diferentes “formas” de la culpa, como la imprudencia, la negligencia y

la impericia en el arte o profesión.

En lo que, a mi actuar profesional se refiere, tal cual la técnica utilizada en la cirugía (ovh) ante los signos y sintomatología (infección de útero/piometra) presente en la paciente (Lola); no existió negligencia, entendida esta como prever lo que era previsible o, habiéndolo hecho, no haber adoptado la diligencia necesaria para evitar el fallecimiento de Lola. Como tampoco, con mi actuar, se configuró la impericia; la cual consiste, en la incapacidad técnica para el ejercicio de una función determinada, profesión o arte. En efecto, como se advierte de la documental que incorporo a esta contestación de demanda, no sólo que poseo título habilitante, sino que además me encuentro matriculada en el Colegio Médico Veterinario hace más de 15 años.

Por otro lado, la culpa —a diferencia de lo que ocurre con la relación causal— se aprecia en concreto, sobre la base de la naturaleza de la obligación, y de las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Mientras que, la relación causal se aprecia, en todos los casos, en forma objetiva y abstracta, prescindiendo de la valoración de la conducta del agente, o de lo que éste efectivamente sabía en el caso concreto.

El art. 1768 del CCCN, regula expresamente las particularidades del deber de resarcir de los profesionales liberales, frente a un sistema de responsabilidad -actual- unificado, que establece, en primer lugar, que el deber de resarcir el daño que pesa sobre los profesionales liberales se rige por las reglas aplicables a las obligaciones de hacer.

Aquí, SS, cobra especial relevancia en la materia el art. 774 CCCN, antes mencionado en cuanto a que la prestación a cargo del experto puede consistir, por un lado, en realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, más allá de su éxito (inc. a) como fue mi prestación de tareas, al realizar todo el tratamiento, cirugía y post cirugía de la paciente; cumplimentando todos los pasos y técnica utilizada para el cuadro que Lola presentaba.

El art. 1768 del CCCN, establece expresamente que el deber de resarcir el daño a cargo del

experto se rige, en principio, por las normas aplicables a la responsabilidad subjetiva.

Esta última disposición, se afinca en el hecho de que, en general, el incumplimiento de los profesionales liberales se concreta por su accionar negligente en la prestación del plan de conducta comprometido y no, como en el caso, la profesional (médica veterinaria), no se compromete en obtener la cura de la paciente.

De lo dicho hasta aquí, el art. 1768 CCCN establece que el profesional liberal responde, por el incumplimiento de la prestación principal, en principio subjetivamente, y es preciso acreditar su culpa para que se patentice el incumplimiento; aplicando las reglas sentadas por los arts. 1724 y 1725 CC yC.

Lo cual, no fue tan si quiera, acreditado sumariamente, en el libelo de la actora; aún, al intentar encuadrar forzosamente la circunstancia de tiempo, modo y lugar, en todo el articulado de los presupuestos de la responsabilidad civil, técnicas que pudiera describirlas como “impericia” o “negligencia” según la percepción de la actora. Y digo percepción, porque no surge de su relato, cuál debió ser la técnica médica veterinaria a utilizar, para el diagnóstico y cuadro de salud que presentaba Lola, al momento de la cirugía.

En su segunda parte, el art. 1768 CCCN, excluye a los profesionales “(...) liberales del sistema de responsabilidad por el hecho de las cosas viciosas o riesgosas y por actividades peligrosas... Por lo tanto, la exclusión se vuelve necesaria al producirse la unificación de las órbitas de responsabilidad, pues supuestos como los enunciados precedentemente, que antes se regían por las normas propias de la órbita obligacional, podrían llegar a recaer —indebidamente— en un régimen de responsabilidad que no es adecuado para regular la cuestión. Por ejemplo, si el deber de resarcir del médico se rigiera por las normas aplicables a la responsabilidad por el hecho de las cosas viciosas o riesgosas (art. 1757 CC y C y ss.), el factor de atribución aplicable sería objetivo —el riesgo—, lo que resulta absurdo dado el contenido de la prestación comprometida por el experto. (...)”.[Véase HERRERA, Marisa; CAMELO, Gustavo; PICASSO, Sebastián, “Código Civil y Comercial de la Nación”,

Comentado, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 1ª Ed., CABA, 2015, Tomo IV, pág. 497 y ss.]

Esta previsión, trasladada a mi accionar como médica veterinaria, en la que muchas veces puede encuadrar en alguna de estas figuras, sea que utilizo cosas por sí riesgosas en el desarrollo de mi tarea profesional (v. gr. bisturí) o como la que desarrollé, que es peligrosa en sí misma (v. gr. operación quirúrgica).

De ello, se deduce, que mi actuar profesional como médica veterinaria, en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la paciente nada tuvo que ver con el perjuicio padecido por la Sra. Marrero, que fue el resultado del riesgo que conlleva una cirugía, cómo lo recepta el organismo de la paciente y su posterior evolución.

En síntesis, del relato de la actora en su escrito de demanda, no queda acreditado con mi obrar, ninguno de los presupuestos, a saber: el acto antijurídico (art.1717 del CCCN), la culpa (arts. 1724 y 1725 del CCCN), relación causal (art. 1726 del CCCN) y mucho menos, el daño que “tenga por objeto la persona, su patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”(arts. 1737, 1738 y 1741 del CCCN) para entender que la Sra. Marrero, posee legitimación activa para entablar la acción de responsabilidad civil por daños y perjuicios en mi contra.

Finalmente, al ser la presente excepción de falta de acción y conforme lo prescripto en el art. 2 de la Ley 10.555; ha circunscrito la manda de ordenar correr traslado a la contraria de las excepciones opuestas al contestar la demanda siempre y cuando tales específicas vías impugnativas respondan a la naturaleza estrictamente procesal, esto es aquellas identificadas con las excepciones de previo y especial» (sic)

Se opone a la procedencia de los rubros reclamados, ofrece prueba y plantea el caso federal.

7.- Con fecha 28/06/2023 la actora contesta el traslado de la excepción planteada.

En primer lugar, niega:

a) haber proferido improperios, manifestaciones vejatorias hacia la persona de la demandada

ni a través de Whatsapp ni de redes sociales ni sitios web;

b) que el presente caso engaste en el que describe la demandada en cuanto a que el secreto profesional se derrumbe ante el requerimiento de un órgano colegiado (Colegio de Médicos Veterinarios) y/o un requerimiento de un órgano judicial;

c) que haya contradicción en el relato de los hechos en el escrito de demanda con la documental acompañada y las fechas;

d) que la demandada hubiere procedido a realizar en la paciente, canalización y fluidoterapia, para luego colocar la premedicación (xilacina, acepromacina y ketamina) con las dosis de acuerdo al peso del paciente y que posterior a ello, se realizara tricotomía y asepsia de la zona quirúrgica;

e) que hubiere habido adherencias y que luego de la liberación del ovario de las mismas en la extirpación reconocida del riñón izquierdo (nefrectomía) frente a la hemorragia profusa se hubiere resuelto la misma;

f) que se hubiere evitado un shock hipovolémico mediante profusa fluidoterapia;

g) que hubiere ligado la arteria renal;

h) que se hubiere continuado con la ovariectomía ligando el útero, realizando transfixión, limpieza de cavidad y de la zona procediendo a suturar en puntos X subcutáneo y piel;

i) que la recomendación de transfusión de sangre hubiere provenido de la Dra. Díaz, siendo uso y costumbre veterinaria que al propietario se le solicita un paciente donante con requisitos para esta práctica y que no existía banco de sangre dada la situación del momento: pandemia;

j) que acto seguido se hubiere realizado la transfusión con “material acorde”, que “viene” esterilizado y cerrado al vacío;

k) que por la situación emocional en la que me encontraba la información no hubiera sido bien receptada;

l) que el relato de la demanda sufra de mitomanía y fabulación;

ll) que con fecha 10/07/2020 la Dra. Díaz no haya visualizado ni ovario ni riñón izquierdo, no surge de la historia clínica ni lo relató en ese momento;

m) que el día de la cirugía me haya explicado el cuadro, el acto quirúrgico y los riesgos a los cuales iba ser sometida Lola;

n) haber consentido la extracción de un riñón.

Seguidamente se expide en torno a la defensa opuesta por la demandada, en los siguientes términos: *«La excepción de falta de acción planteada resulta poco clara en cuanto a su exposición y los fundamentos de su exposición por las siguientes razones:*

Destacada doctrina se refiere a la excepción de defecto legal para la cual consideramos oportuno citar “El libelo oscuro o defecto legal consiste en a) no individualizar debidamente los sujetos, b) no determinar con precisión y claridad el alcance cuantitativo y cualitativo de lo que se pida c) no hacer una exposición sucinta de los hechos esenciales o si éstos son contradictorios”. El resaltado me pertenece. Comentario al art. 184 inc. T° 1 pág. 645 Mariano A. Díaz Villasuso. Ed. Advocatus. -

El resaltado del párrafo anterior viene a colación en este punto en tanto estimamos que dado que los sujetos están identificados – no ha sido cuestionado este punto- (incluido el saneamiento inicial) y los hechos han sido relatados al detalle de manera conteste – no hay contradicción - que lo tachado de oscuro y defectuoso por la demandada es el objeto.

Que estimados, dejar planteada esta disquisición: también afirmada por esta misma prestigiosa doctrina citada: “el objeto de la pretensión es el efecto jurídico que mediante ella se persigue, que se debe descomponer en objeto inmediato o clase de pronunciamiento que se reclama (condena, declaración, ejecución, etc.) y el objeto mediato, es decir el bien de la vida sobre el cual debe recaer el pronunciamiento (v.gr. suma de dinero o el inmueble cuya restitución debe condenarse al demandado). A ambos aspectos del objeto de la pretensión procesal se refiere el art. 175 inc. 5 cuando dispone que la demanda expresará la petición en términos claros y precisos, en tanto que solo se refiere al objeto mediato cuando el inc. 3

determina que se debe designar con exactitud la cosa que se demande.” Comentario al art. 175. Tº 1 pág. 569 ob. Cit.

En el escrito de demanda el objeto inmediato es la declaración de la responsabilidad profesional por mala praxis fundada en el art. 1768 del CCCN por parte de la demandada y la condena de pago del monto reclamado, configurando el objeto mediato la suma de dinero reclamada al citar los rubros integrativos de la demanda.

Por ello y teniendo en cuenta que la demandada ha podido responder a estos extremos e incluso desarrollarlos claramente y en concordancia a lo que esta parte afirmado no es viable la procedencia de la excepción planteada.

La demandada afirma que el hecho en que se funda la demanda es en los art. del Código de fondo relativos a la Locación de Servicios (1251, 1252, 1278, 773 y 774 CCCN), para arribar al art. 1768 relativo a la Responsabilidad Profesional, en la cual el factor de atribución es de carácter subjetivo.

Esto ha sido sostenido por esta parte en el escrito introductorio de demanda, es más: ambas partes concordamos en el encuadre jurídico otorgado a la relación jurídica habida entre las partes y a los hechos generadores del reclamo.

En cuanto a la diferenciación de las obligaciones de hacer y de resultados y el factor de atribución correspondiente a las mismas que relaciona en su escrito la demandada, esta parte también reitera (y remite a lo expresado en escrito inicial) lo ya afirmado, esto es: la mala praxis endilgada la Dra. Díaz ha sido atribuida – que se pretende sea probada en la etapa procesal oportuna – en virtud de la imprudencia y negligencia desarrollada por la profesional demandada.

El desenlace fatal de la paciente Lola ha sido la consecuencia del obrar de la galena hoy demandada. Por lo tanto, el obrar es lo acusado de imprudencia y negligencia y así parece también haberlo entendido la demandada al relatar la realidad de los hechos cuando describe minuciosamente lo que confiesa en su escrito de responde – sin ofrecer prueba

alguna más que sus dichos sobre lo actuado el 13/07/2020-.

Cuando la demandada relata el 1734 CCCN en cuanto a la carga de la prueba corresponde a quien alega, baste repasar la prueba ofrecida por esta parte para acceder a la convicción de quien debe fallar en el presente caso, que luego de la etapa procesal de audiencia preliminar será determinante para la admisión y producción de la prueba y por ende, la acreditación de los hechos.

Esta parte ha considerado el actuar de la Dra. Díaz como un caso comprendido en el art. 1768 del CCCN, como una obligación de medios en tanto en ese actuar se incurrió en la culpa que configura el factor de atribución subjetivo de responsabilidad.

El art. 1724 establece: “la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión”. En el caso que nos convoca: la culpa: se da cuando se hace lo que no se debe o más de lo debido (Trigo Represas, Rep. de daños por mala praxis médica cit. pág. 131 N° 8) en el caso, la misma Dra. Díaz manifestó por conversación vía Whatsapp: que había en Lola una supuesta “malformación: el riñón estaba debajo del útero”, que al querer seccionar el ovario se despegó, “se le salió” (sic) el riñón incluido en esa extracción y que por eso le cortó la arteria renal, lo que llevo a que Lola perdiera muchísima sangre generando una severa descompensación, y en escrito de contestación que lo ratifica:... “se observan adherencias, lo que dificulta la ligadura de la arteria ovárica, para su mayor visualización se procede a la utilización de diferentes tipos de separadores para ampliar el campo operatorio. Y para no forzar el útero, ya que este se encontraba en condiciones friables, durante dicha maniobra se observa adherencias en la zona perirrenal, en intento de liberar el ovario de dicha adherencia empieza una hemorragia profusa, impidiendo una buena visión del campo quirúrgico, la cual disminuye al ligar la arteria renal. Una vez resuelta la hemorragia, se decide, dadas las adherencias antes mencionadas, realizar una nefrectomía (extirpación del

riñón), es decir que la decisión de extirpar el riñón fue tomada deliberadamente, habiendo descubierto dichas adherencias y lo friable de los tejidos, y en definitiva habiendo descubierto la malformación se decidió avanzar en la extirpación sin evaluar debidamente las consecuencias, esa decisión quirúrgica que determinó la descompensación por hemorragia en el cuerpo de una perrita caniche, para lo que una fluidoterapia evidentemente no fue suficiente.

En este sentido, lo determinante será lo que la pericia medico veterinaria exprese como causal a los fines de acreditar el deceso posterior como consecuencia de ese actuar; y la negligencia constituida por una actividad que se omite para evitar daños y por oposición a la diligencia fue lo desarrollado por parte de la Dra. Díaz tuvo lugar no solo al omitir contar con los elementos que hubieran podido transfundir oportunamente a Lola - dado que me llamó por teléfono, me avisó de lo mal que había salido la cirugía, por ende esperó a que llegara de mi trabajo cerca del mediodía ya – para recién allí yo pudiera conseguir un perro donante de sangre, es decir con posterioridad a todo el evento quirúrgico (el cual había comenzado inmediatamente dejé a Lola), allí salgo a toda velocidad de la veterinaria en Bo Las Flores a Bo Res. Vélez Sarsfield a buscar al perro de mi vecina del Barrio Sra. Rebeschì quien trajo a su perro de tamaño apto para transfundir y con la Sra. Rebeschì presente en todo momento fue que la tuvieron lugar las manipulaciones manuales para que funcionara el mecanismo de transfusión sanguínea con la bolsa que la Dra. Díaz había conseguido en préstamo en esos momentos previos – en base al relato que ya expresé en escrito inicial. La demanda no es el momento de la prueba, es un acto procesal de postulación de la pretensión, por eso no se acusa recibo de comprensión respecto a la afirmación “lo que en la obligación de medios equivale a probar la culpa; todo lo cual, SS, no surge del relato de la demanda, ni aun al mencionar los presupuestos de responsabilidad”. (apartado C, párr. 13). Precisamente por este motivo, es que fue solicitada la Prueba Pericial Médico Veterinaria sobre la Historia Clínica confeccionada por la profesional Dra. Díaz.

Asimismo se citó doctrina y jurisprudencia que afirman que la falta de estudios adecuados, incluso la veterinaria actuante detectó en la ecografía del 10/07/2020, tal como relata en la contestación que no se visualizaban ni ovario ni riñón izquierdo, e igualmente se avanzó con la cirugía, no se previó la eventual necesidad de transfusión sanguínea, lo cual agrava la situación SS, tampoco se prescribieron estudios complementarios más específicos en esta etapa de diagnóstico y en los pre quirúrgicos –teniendo en cuenta también lo errático del diagnóstico a lo largo de 13 días del cuadro de Lola - actitudes y decisiones todas estas que configuran y contribuyen a encuadrar en las formas de la culpa atribuida a la demandada. Se afirmó y se reitera en este acto que por exceso y defecto en el actuar médico de la Dra. Díaz se llegó al fallecimiento de Lola. Lo cual, esta parte estima fue claro ab initio. En definitiva SS, no se advierte virtualidad suficiente para acoger esta excepción planteada, al contrario debe ser rechazada totalmente ya que la demandada ha contestado – si bien no tiene otra oportunidad procesal para hacerlo – pero argumentativamente no puede sustentarse una excepción de defecto legal cuando se ha contestado la demanda en todos sus términos, tal como surge del escrito.

A los fines del defecto legal atribuido a la demanda y como inferencia lógica no se advierte dado que la parte demandada ha podido contestar, dar su versión de los hechos y la aplicación del derecho.

De haber defecto legal esto no podría haber acontecido – más allá, insisto – que en virtud del trámite abreviado oral no haya otra oportunidad para contestar. Pero, en esta línea argumentativa, queda desechado por el tenor mismo de la contestación formulada por la demandada que ha respondido todos los puntos planteados en demanda.

Ya hemos mencionado el largo derrotero procesal para obtener la copia de la historia clínica en tanto es propiedad del paciente, pero bajo resguardo y custodia del profesional médico quien debe expedir copia ante el simple requerimiento del paciente (Ley 26.529).

Cabe acotar que no bastó la necesidad de obtener secuestro usando la vía judicial sino que

en oportunidad a la ampliación del embargo solicitada por esta parte (frente a la sustitución solicitada por la demandada), la demandada se opuso, dando lugar a un incidente cuya resolución en relación a las costas esta parte no impugnó tal como correspondía y asistía a su derecho simplemente a los fines de que este proceso continúe sin más dilaciones para finalmente terminar ampliándolo.

Si la demandada no ha querido acercar al pleito eximente de su responsabilidad y medios probatorios que avalen sus afirmaciones no ha sido por deficiencia u oscuridad del escrito de demanda, sino por la orfandad probatoria con la que cuenta».

Ofrece prueba y reitera su reserva del caso federal.

8.- Con fecha 04/10/2023 se llevó adelante la audiencia preliminar prevista por el art. 3 de la Ley 10.555, oportunidad en la cual, atento a no haberse llegado a un acuerdo entre las partes, se procedió a proveer las pruebas ofrecidas.

9.- Luego de diligenciarse la prueba efectivamente incorporada al expediente, el día 05/03/2024 se celebró la audiencia complementaria en los términos del art. 4 del citado plexo normativo.

En dicha oportunidad se recibió la declaración de las partes, testigos y peritos y luego las partes expresaron sus respectivos alegatos.

Dictado y firme el decreto de autos para resolver en definitiva, quedó la causa en condiciones de estudio y resolución.

Y CONSIDERANDO:

I.- Teniendo en cuenta que en la estructura del proceso oral se prescinde de formas sacramentales, y en consonancia con los nuevos paradigmas generales, es deber de este Tribunal redactar esta sentencia en términos claros y comprensibles para el justiciable, prescindiendo de formulaciones y citas dogmáticas (cfr. Anexo I del Acuerdo Reglamentario N° 1815 Serie A del 03/08/2023, Protocolo de Gestión del Proceso Civil Oral, punto 7).

Puesto en esa labor, anticipo que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de

las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia (cfr. CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros) y tampoco tienen *«el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa»* (art. 327 in fine CPCC).

II.- Marco normativo. En primer lugar, corresponde fijar el marco normativo a cuyo amparo debe juzgarse la procedencia de la demanda y las defensas planteadas, partiendo de la premisa de que *«la ciencia veterinaria, al igual que sucede con la médica, no es infalible ni todo lo puede, por lo que se hace necesario establecer los parámetros de la responsabilidad del veterinario que actúa en el ejercicio de su profesión y dotarle de la seguridad jurídica necesaria en el cumplimiento de las obligaciones que de ello dimanen»* (Gil Membrado, Cristina: *Régimen jurídico civil de los animales de compañía*, Dykinson, 2014, p. 237).

II.1.- Así, el art. 1768 del CCyCN prescribe: *«La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la Sección 7a, de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757»*.

En línea con dicho precepto, existe suficiente consenso en la doctrina autoral y jurisprudencial en orden a que, en el marco de un tratamiento veterinario asistencial o curativo, el grueso de los deberes del profesional son obligaciones de medios, esto es, debe desempeñarse con la diligencia exigible a su condición, proporcionando a sus pacientes -los animales tratados- todos los cuidados que requieran, según el estado de la ciencia y la denominada *lex artis ad hoc*, aunque a la postre no se llegue a obtener su recuperación o sanidad (cfr. Monterroso Casado, Esther: *Aspectos legales y responsabilidades derivadas de la práctica veterinaria*; Servet, 2005, pp. 54 y ss.; Fumarola, Luis A.: *Incidencias del Código Civil y Comercial*.

Responsabilidades profesionales y especiales, Hammurabi, 2016, pp. 405 y ss., con cita de López Mesa, Marcelo J. – Trigo Represas, Félix: *Responsabilidad civil de los profesionales*, Lexis Nexis, 2005, p. 590 y ss.). En otras palabras, la obligación de medios comprende «la utilización de medios y de remedios a disposición de la ciencia veterinaria y del profesional en atención al lugar donde efectúa el tratamiento y la información al cliente, en este caso el dueño o el poseedor del animal acerca del diagnóstico, del tratamiento y del pronóstico, así como de los riesgos, especialmente cuando la técnica a realizar sea quirúrgica, y en mayor medida si se trata de una intervención estética, es decir, no curativa» (Gil Membrado, Cristina: *Régimen jurídico civil de los animales de compañía*, Dykinson, 2014, p. 239). En definitiva, y como regla general, el servicio prestado por el veterinario consiste «en realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito» (art. 774 inc. a CCyCN). No asegura la curación, pero compromete una actividad técnica y científica que es lo que tipifica sus obligaciones, siendo precisamente esta falta de técnica y ciencia lo que configura la culpa médica, la cual generalmente se manifiesta como impericia, cuando faltan conocimientos científicos que el ejercicio de la profesión requiere; o negligencia, cuando pese a estar debidamente capacitado, obra descuidadamente en el caso concreto, es decir, con abandono, descuido, apatía, omisión de precauciones etc.

Si se pone foco en la cuestión probatoria, la responsabilidad profesional de los médicos veterinarios se halla sometida a las mismas reglas de la responsabilidad en general y, por tanto, requiere para su configuración, de los mismos elementos comunes que cualquier hipótesis de responsabilidad civil.

Serán las constancias procesales las que pongan de manifiesto qué ocurrió en la emergencia, y posibiliten al juzgador determinar si el hecho en cuestión -en el caso, la muerte de Lola- sucedió por una actuación culpable de la profesional demandada, o por una o varias causas ajenas derivadas fortuitamente del propio estado de salud del paciente animal o de algún otro imponderable.

Tal como acontece en los supuestos de mala praxis en materia de medicina humana, tanto el dueño del animal como el profesional demandado deben asumir una actitud activa frente a la prueba, ocupándose por acercar al proceso los elementos convictivos esenciales que justifiquen sus respectivas estrategias procesales; el actor deberá demostrar la concurrencia de los elementos que condicionan la responsabilidad civil del veterinario (daño, culpa y nexo de causalidad), el profesional de la medicina -por su parte- deberá argumentar y acreditar que el hecho dañoso invocado no configuró la clásica tipificación de falta médica o mala praxis reprochable.

II.2.- Avanzando en el análisis y en prieta síntesis, la actora sostiene que la demandada no realizó un diagnóstico preciso y certero; que al realizar la cirugía y el postoperatorio, no actuó de acuerdo a las reglas de la *lex artis*; y que confeccionó de modo deficiente de la historia clínica.

II.2.a.-Diagnóstico. *«El diagnóstico es el procedimiento con el que se identifica la enfermedad que sufre el animal (por sus señales, síntomas y resultados de laboratorio), constatando la naturaleza y trascendencia de la misma. Esta actuación resulta relevante, ya que dependiendo de la misma se efectuará un tratamiento u otro. El veterinario que comete un error profesional sobre el diagnóstico de la lesión o en la enfermedad sufrida por el animal puede incurrir en responsabilidad si no adoptó los medios o no empleó las técnicas adecuadas, según impone el estado de la ciencia veterinaria... Ahora bien, un simple error diagnóstico o terapéutico no puede constituir siempre falta de un deber de cuidado, ya que es aceptable el error de valoración o de juicio: en ocasiones, la sintomatología puede confundirse o puede que la enfermedad se encuentre en sus primeros episodios y sea difícil un reconocimiento de la misma. En tales casos, no es posible atribuir culpa alguna al profesional. En sentido contrario, en el supuesto de que nos encontremos ante una ignorancia inexcusable, existirá negligencia del veterinario si no emite tal diagnóstico y, como consecuencia, se produce el daño. Por ejemplo, una serie de signos reveladores de una*

enfermedad o una sintomatología claramente distinguibles entre los profesionales para realizar una evaluación precisa. Por otro lado, una conducta adecuada a la lex artis exige la realización de las pruebas necesarias para emitir un diagnóstico preciso, por lo que también se podrá atribuir al veterinario la responsabilidad si el diagnóstico fue equivocado por omitir la realización de las pruebas oportunas. La jurisprudencia considera que incluso en el caso de que no resultase probado que la realización de la prueba pertinente hubiera sido suficiente para evitar el fallecimiento del animal se podría atribuir dicha responsabilidad, ya que la relación causal existe desde el momento en que se no se realizaron tales pruebas para emitir el diagnóstico. En consecuencia, debe entenderse que, si se hubieran realizado las mismas, se podría haber descartado la existencia de la enfermedad o, en el caso de que se hubiera detectado la misma, podría haberse realizado un tratamiento que hubiera permitido la curación o la supervivencia del animal... Por lo tanto, para que el veterinario quede liberado de responsabilidad no sólo deberá observar los síntomas y signos que presenta el animal, sino también realizar las comprobaciones oportunas mediante el uso de procedimientos de creación de imágenes y resultados de laboratorio» (Monterroso Casado, Esther: Aspectos legales y responsabilidades derivadas de la práctica veterinaria; Servet, 2005, pp. 110/111).

II.2.b.-Tratamiento quirúrgico. *«... sólo una inapropiada intervención quirúrgica o una falta de destreza y de conocimientos en la propia intervención o en los tratamientos postoperatorios (en definitiva, una actuación disconforme con la lex artis) acarrea la responsabilidad del cirujano veterinario cuando, como consecuencia de la misma, se produce el daño. Daño que puede consistir en una lesión o, en el peor de los casos (y por desgracia el supuesto más frecuente cuando existe una reclamación judicial), el fallecimiento del animal... Respecto a la necesidad y demora en el tratamiento, debemos apuntar que el veterinario tiene el deber de prestar asistencia médica al animal cuando lo precise. De esta manera, ante el retraso injustificado de un tratamiento o una intervención que origina un*

daño, incurrirá en responsabilidad... Por último, es preciso advertir que esta actuación diligente no sólo debe observarse en el tratamiento quirúrgico, sino también en el postoperatorio» (Monterroso Casado, Esther: Aspectos legales y responsabilidades derivadas de la práctica veterinaria; Servet, 2005, pp. 112/113).

II.2.c.- Historia clínica.*«La asistencia a los animales tratados en cualquier centro, clínica u hospital veterinario genera una serie de información que se registra en la historia clínica y que permite la atención continuada al animal. Además de los datos clínicos, su tratamiento y evolución, se deben incluir las pruebas practicadas. los juicios emitidos, el consentimiento informado del dueño del animal a los tratamientos o intervenciones practicadas que supongan un riesgo, así como las razones que motiven la modificación de un diagnóstico o un tratamiento. Para que la historia clínica constituya un documento legal objetivo debe reunir los requisitos de rigurosidad e integridad, claridad, precisión e identificación... La carencia de la historia clínica impide contar con uno de los elementos más relevantes de prueba. Además, cuando en la historia se cometen errores o defectos, esta carencia genera una impresión negativa y su validez como medio de prueba queda en entredicho, lo que perjudica al profesional, que tiene el deber de confeccionarla y anotar en ella todos los datos necesarios conforme a la ciencia veterinaria» (Monterroso Casado, Esther: Aspectos legales y responsabilidades derivadas de la práctica veterinaria; Servet, 2005, pp. 136/138).*

III. Responsabilidad. Con arreglo a estas premisas, cabe examinar a continuación las probanzas reunidas en la causa, que sean relevantes para decidir la controversia.

III.1.- En operación de fecha 20/02/2024 se incorpora el dictamen emitido por la perita oficial veterinaria Dra. Ana María Gargevcich.

En primer término, se solicitó a la perita que determinara, en base a las constancias de autos, la **causa del deceso de Lola**.

La auxiliar respondió: *«En base a las constancias documentales obrantes en autos y a las aportadas por la demandada, la causa del deceso de Lola, canino, hembra, Caniche toy, de 5*

años, fue la consecuencia de una sucesión de acontecimientos desafortunados que comienzan el 2 de julio de 2020 con el primer diagnóstico de enfermedad respiratoria y la siguiente administración empírica de fármacos. Se le administró vía parenteral dexametasona y Penicilina estreptomicina, y se le indicó tratamiento oral de Bactoprofen (tetraciclina, cloranfenicol y prednisolona) durante 7 a 10 días.

Dos días después y ante un cuadro clínico que lejos de mejorar, empeoraba, la Medica Veterinaria Díaz, María Belén, indicó cambiar de fármacos. En esta oportunidad fue medicada con Enrofloxacin 50 mg (antibiótico).

Ante la no evolución favorable, el día 7 de julio de 2020, la Medica Veterinaria Díaz, María Belén, indica Análisis de sangre y Ecografía. Si bien consta en el expediente el resultado del análisis de sangre realizado, no consta en el expediente, el informe de la ecografía. Hasta aquí no hay un diagnóstico DEFINITIVO que surja de un examen semiológico completo, ni de pruebas complementarias de diagnóstico.

Ante la presencia de un útero con contenido y aumento de glóbulos blancos y neutrófilos tóxicos, tal como consta en la ficha clínica confeccionada manualmente por la Med. Veterinaria, se indica cirugía a realizarse el 13 de julio de 2020.

Ahora bien, el resultado del laboratorio es incompleto y no puede ser tomado como un análisis prequirúrgico porque faltan elementos importantes de la química sanguínea como la determinación de urea en sangre y glucemia. La determinación de la uremia es fundamental en este caso, ante la sospecha de piometra, porque esta enfermedad produce Insuficiencia Renal como explicaré más adelante. Por otro lado, antes de la cirugía se deberá corregir ese parámetro para estabilizar el paciente y proceder luego a la anestesia general y cirugía.

Con respecto al examen ecográfico, el ecografista debe informar sobre la anatomía ecográfica normal y eventualmente el hallazgo de imágenes alteradas que presenta cada patología en particular. Se debe recorrer el abdomen y observar cada órgano alojado en el mismo. Se describirán FORMA, TAMAÑO, LOCALIZACIÓN, ECOESTRUCTURA de cada

órgano. Además la evaluación ecográfica exige la visualización de los órganos en dos cortes como mínimo, cortes transversales y longitudinales.

Por otro lado, los riñones son órganos sencillos de ser evaluados. Debido a su posición más craneal (adelante), el riñón derecho es más difícil de ecografiar que el riñón izquierdo. Por lo tanto, es prácticamente imposible que no se haya visualizado el riñón izquierdo como refiere la Med. Vet. Díaz, M. Belén en su comparecencia cuando dice "NO SE VISUALIZARON NI OVARIO NI RIÑÓN IZQUIERDO".

Los ovarios se visualizan en la ecografía de manera diferente según el estadio del ciclo estral.

El útero con colecta o "contenido" se visualiza perfectamente en una ecografía... »(sic).

Explica luego el ciclo estral de la perra y sus cuatro estadios (proestro, estro, diestro y anestro).

A continuación discurre acerca la definición, etiología, fisiopatología, signos clínicos, diagnóstico y tratamiento de piometra, en los siguientes términos: «Definición. La piometra canina es una enfermedad diestral de las hembras maduras con signos sistémicos provocados por lesiones genitales y extragenitales.

Etiología. La etiología o causa de la enfermedad es una complicación de la Hiperplasia Endometrial Quística (HEQ) que se desarrolla durante el diestro.

Fisiopatología. El período diestral de las hembras normales no preñadas dura aproximadamente entre 60 a 70 días cuando el útero se encuentra bajo la influencia de la progesterona producida por el cuerpo lúteo ovárico. La progesterona induce la formación de las glándulas endometriales y la secreción de leche uterina para mantener el desarrollo del embrión antes de su implantación. En este momento el cuello del útero se encuentra funcionalmente cerrado. La HEQ (Hiperplasia Endometrial Quística) es una respuesta uterina anormal a la progesterona con excesiva proliferación de moco e infiltración de glóbulos blancos. A menudo se observa una descarga vulvar mucoide y rojiza. Al final del

diestro, cuando los niveles de progesterona declinan, la HEQ (Hiperplasia Endometrial Quística) se resuelve. En otros casos, ocurre una piometra (pio.pus, metra.luz uterina). Esto acontece cuando esa exacerbada secreción uterina se contamina por vía ascendente con bacterias, generalmente Escherichia coli proveniente del intestino.

La deshidratación durante el curso de la enfermedad podría ser suficiente como para causar una pobre perfusión renal y uremia. Pero también durante la piometra, se depositan en los capilares glomerulares, complejos inmunes provocando una glomerulopatía. Las lesiones glomerulares no son lo suficientemente severas como para causar una falla renal y esta glomerulopatía se resuelve después que la piometra es tratada por medio de la ovariectomía. Como resultado de la incapacidad para concentrar la orina por parte del riñón dañado, ocurre poliuria (orinar mucho volumen) y polidipsia (tomar mucha agua) compensatoria.

La acumulación de glóbulos blancos neutrófilos en el útero, causa una masiva producción de glóbulos blancos, lo que da lugar a un elevado conteo de neutrófilos circulantes con desviación a la izquierda (aumento de glóbulos blancos inmaduros en sangre). Pueden aparecer también algunos neutrófilos tóxicos en el hemograma.

Signos clínicos. Los signos clínicos aparecen en perras de más de 6 años de edad y entre 1 a 8 o 10 semanas después de observado el Estro. Los signos clínicos varían de acuerdo a la severidad de la enfermedad uterina, estado del cuello del útero, duración de la enfermedad, presencia o ausencia de enfermedades concomitantes no relacionadas. Los signos más frecuentemente observados incluyen depresión, anorexia, descarga vaginal que puede ser escasa o profusa, de color amarillento, gris, rojo o chocolate., generalmente con olor fétido, vómitos, diarrea, polidipsia, poliuria, distensión abdominal, dolor abdominal a la palpación, dificultad para incorporarse con los miembros posteriores debido al dolor abdominal.

Las perras con piometra que cursan con el cuello del útero cerrado, tienden a estar más deprimidas y toxémicas que las perras que cursan con el cuello del útero abierto ya que en

este caso el drenaje de la secreción disminuye la toxemia.

La temperatura rectal es usualmente normal, pero puede estar elevada y a veces en perras severamente toxémicas la temperatura puede estar por debajo de lo normal. La temperatura normal en el perro es de 38 C.

Diagnóstico. Hallazgos de Laboratorio. Aumento de Neutrófilos (neutrofilia), neutrófilos inmaduros, disminución de Neutrófilos (neutropenia) cuando hay severa toxemia, condición poco común, Anemia, Hiperproteinemia por aumento de la concentración de globulinas séricas, Uremia generalmente aumentada, Creatinina normal o aumentada según el daño renal provocado por la piometra, Proteinuria por el daño renal.

Radiología y Ecografía. Necesarias para confirmar el diagnóstico. En ambas se observara un útero aumentado de tamaño, con colecta en su interior.

Tratamiento. La técnica quirúrgica de Ovariohisterectomía es el tratamiento que mejores resultados ha ofrecido en pacientes con piometra. Si bien existen tratamientos hormonales para tratar la enfermedad, estos se destinan a hembras reproductoras de alto valor y cuando el dueño entiende cuales son los riesgos de no realizar la cirugía porque en un alto porcentaje de hembras a las que se les ha tratado hormonalmente, la patología recidiva (regresa) con las consecuencias que ello conlleva.

Además se debe corregir la hidratación y el medio interno con fluidoterapia según la necesidad del paciente y su estado clínico. También, la administración de antibióticos de amplio espectro deben ser administrados para controlar la infección bacteriana secundaria.

Ahora bien, en el expediente que figura en autos, hay un registro de los celos desde que Lola comenzó a ciclar por primera vez y se observa en esos registros un celo regular, esperable en una hembra canina sana. Los celos se manifiestan en la paciente cada 5 o 6 meses. Considerando que el último celo fue el 24 de febrero de 2020, los síntomas de piometra, deberían haberse manifestado en el periodo diestral o sea entre 30 a 60 o 70 días después de esa fecha, es decir a fines de abril o principios de mayo, y no dos meses más tarde, o sea en

julio de 2020, fecha en que fue diagnosticada la piometra de Lola, ya que en esta fecha la perra debería haber estado en pleno anestro.

Además en la ficha clínica elaborada por la Medica Veterinaria Díaz, M. Belén, no menciona síntomas como polidipsia, poliuria, dolor abdominal, secreción vaginal y algún otro síntoma como los descriptos más arriba. En cuanto a la temperatura corporal, en la ficha clínica la Med. Vet. Díaz refiere una temperatura de 39° C, cuando en general, durante el transcurso de la enfermedad la temperatura se mantiene normal o es subnormal en una piometra avanzada.

Por último, explicaré brevemente qué es el shock hipovolémico que fue en definitiva el motivo final del deceso de la perrita.

La disminución de la volemia (cantidad de sangre circulante de un individuo) o hipovolemia conduce al shock Hipovolémico (hemorrágico) y es la incapacidad del organismo para proporcionar una perfusión adecuada de sangre oxigenada y nutrientes a los tejidos, para satisfacer las necesidades metabólicas. Durante el shock hipovolémico por hemorragia aguda, el paciente experimenta signos clínicos como taquicardia, hipotensión, tiempo de llenado capilar disminuido, miembros fríos, disminución de la producción de orina, piel y mucosas pálidas y estupor. De no ser instaurado un tratamiento adecuado y urgente, el shock conduce indefectiblemente a la muerte del animal.

Las maniobras indicadas para tratarlo son detener la hemorragia por medios mecánicos y la fluidoterapia agresiva con hemoderivados (sangre entera), medicamentos vasopresores, y oxigenación de forma rápida. Sin las maniobras antes mencionadas, el resultado será la muerte del animal en cuestión por falla multiorgánica...» (sic).

Al punto de pericia referido a la **vinculación entre el accionar desplegado por la demandada con el deceso de Lola**, la experta manifestó: «No consta en el expediente una historia clínica, resultado de un examen semiológico completo, que me permita conocer el estado clínico del animal y el motivo de la consulta. Tampoco consta en el expediente un

diagnóstico definitivo, informes de pruebas complementarias de diagnóstico (ecografía, radiología) e informes completos de análisis de laboratorio.

Según el registro de los celos de la perra, es improbable que el diagnóstico de la enfermedad se haya realizado en el mes de Julio ya que como explique en el punto de pericia anterior, el diagnóstico debería haberse realizado dos meses antes.

La malformación que menciona la Med. Vet. “el riñón estaba debajo del ovario” no está descrita como tal en la literatura veterinaria (aunque eso no significa que pueda existir). La decisión de realizar una nefrectomía durante la OVH, es una decisión que la profesional en su rol de cirujana, tuvo que adoptar ante el imprevisto que ella relató.

Es evidente que hubo una hemorragia profusa durante la cirugía porque la Med. Vet. indica una transfusión y a las pocas horas la perra muere por shock hipovolémico.

Dicho esto, es evidente la vinculación del accionar desplegado por la profesional Med. Vet. Díaz, M. Belén, con el deceso de Lola, porque fue la única profesional que intervino en este caso, según consta en autos» (sic).

Respecto a la **observancia o inobservancias de las buenas prácticas pre y post quirúrgicas en las cirugías denominadas ovariectomía en relación a las desarrolladas sobre Lola el 13/07/2020**, la auxiliar respondió: *«Una vez decidida la Ovariectomía (OVH), previo diagnóstico definitivo de la enfermedad, el Médico Veterinario debe realizar siempre un examen Prequirúrgico. El examen Prequirúrgico es un conjunto de pruebas previas que se realizan antes de una cirugía para conocer el estado de salud general del animal. Las pruebas de laboratorio, junto al examen clínico, electrocardiograma, radiografías y ecografías brindan información sobre la probabilidad de que el paciente pueda afrontar favorablemente una intervención quirúrgica. El examen Prequirúrgico evitará que el paciente llegue al quirófano en condiciones riesgosas, capaces de incrementar la morbimortalidad operatoria y post operatoria. De los exámenes prequirúrgicos surge el Riesgo Anestésico, que según la clasificación ASA (American Society of Anesthesiologist)*

clasifica al paciente entre los grados 1 al 5 de acuerdo con su estado sistémico y el riesgo frente al procedimiento. Con el ASA y el examen clínico del animal se elabora el Riesgo Quirúrgico. La única situación médica en la cual se prescinde del examen prequirúrgico es la emergencia donde la actuación debe ser inmediata.

El examen Prequirúrgico debe incluir Examen de Laboratorio, Hemograma, Química Sanguínea (donde se evalúa el perfil hepático y renal) y Pruebas de Coagulación. Es importante contar con un examen clínico exhaustivo del aparato cardiocirculatorio, que además deberá contar con el registro electrocardiográfico (ECG) y en casos puntuales un ecocardiograma y medición de la presión arterial a fin de diagnosticar la existencia de cardiopatías y definir el estado hemodinámico del paciente.

La radiografía de tórax y abdomen nos ofrece imágenes de pulmones, corazón y órganos abdominales con las cuales podemos descartar o confirmar posibles patologías.

En algunos casos, además de las pruebas mencionadas y dependiendo de la patología diagnosticada, serán necesarias otras pruebas de diagnóstico complementarias como la Ecografía.

El caso que nos ocupa, la cirugía del Canino llamada LOLA, no consta en el expediente un examen Prequirúrgico completo como el descripto Más arriba:

Con respecto a las Prácticas Postquirúrgicas, el paciente debe ser monitoreado constantemente por el Médico Veterinario confirmando la evolución del animal y el estado de la zona quirúrgica. Se administran medicamentos indicados para disminuir el dolor, para evitar infecciones, y se realizará la toilette de la herida. Se evaluará la consciencia, la temperatura corporal, la hidratación y las constantes fisiológicas. Se mantendrá al paciente en un lugar limpio y se lo higienizará permanentemente.

Según expresa la Medica Veterinaria Díaz, M. Belén, transcurrió poco tiempo entre la finalización del acto quirúrgico, el llamado al propietario del animal, la realización de la transfusión, las maniobras de resucitación y la muerte del animal, por lo tanto no hubo

tiempo de realizar los cuidados postquirúrgicos arriba mencionados. Sé actuó, a mi entender, en forma correcta, en este momento crítico de la situación que atravesaba el animal» (sic).

Respecto a la **completitud en relación a la autorización para cirugía y la confección de la historia clínica de Lola**, la perita sostuvo que la autorización de cirugía confeccionada por la demandada era «*deficiente en cuanto a su completitud*» porque carecía «*de datos importantes a tener en cuenta, como el diagnóstico de la enfermedad, el objetivo de la cirugía, el riesgo quirúrgico, el tipo de anestesia a la cual será sometido el animal, la aceptación o no de exámenes complementarios*». Reiteró que «*en este caso en particular, no hay en el expediente una historia clínica confeccionada detalladamente. Tampoco una Ecografía con su informe correspondiente que permita arribar a un diagnóstico (piometra) y por lo tanto su indicación de tratamiento quirúrgico*» (sic).

Asimismo, en relación a la existencia de **bancos de sangre** en la Ciudad de Córdoba para ser utilizados en cirugías caninas, la perita acompañó fotocopia de foto de Instagram donde se observa que en Julio de 2020 estaba funcionando el Banco de Sangre de Eva Inguerman Veterinaria, aunque aclaró que «*en la actualidad, la disposición de bolsas de sangre no es continua. En caso de ser necesario, son los dueños de los pacientes los que se encargan de conseguir un perro donante para determinada situación. Hay pocos propietarios de animales que rutinariamente los ofrecen como donantes de sangre, por lo cual, en general, los bancos de sangre en la ciudad de Córdoba no disponen permanentemente sangre para ser transfundida*» (sic).

Sobre «**la posibilidad de la existencia de una malformación en riñón y útero que implique que el primero se encuentre debajo del ovario y no fuera perceptible de exámenes prequirúrgicos**», la perita indicó «*que el “riñón se encuentre debajo del ovario” es una malformación que no se ha descripto hasta el presente en la literatura veterinaria. ¿Por otro lado, la pregunta es...? el riñón debajo del ovario en qué posición? Si el animal está en estación (o sea parado en sus cuatro miembros), y es observado de costado, el ovario*

se encuentra más abajo que el riñón y más atrás. Si el animal se encontrara en decúbito dorsal (es decir acostado sobre su espalda y lomo), topográficamente, el riñón se encuentra más abajo y el ovario más arriba y más atrás. Como malformación, esta posición del riñón debajo del ovario, no está descripta».

El dictamen de la perita oficial luce coherente, no exhibe contradicciones que lo priven de valor probatorio y proporciona las razones que le permitieron a la profesional interviniente arribar a sus conclusiones, en función de los elementos ponderados para su elaboración y la metodología utilizada, a lo que cabe añadir las garantías que rodean su designación (por el Tribunal y por sorteo) que hacen presumir su mayor imparcialidad y, consecuentemente, mayor convicción (cfr. TSJ, Sala CyC, “Cepulver Juan Porfirio c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Dirección de Aguas y Saneamiento – Daños y Perjuicios – Recurso de Casación”, Sent. N° 57, 07/08/2007).

Es cierto que la perita de control ofrecida por la parte demandada produjo un informe en disidencia parcial. Sin embargo, considero que en dicho informe no se demuestran desaciertos o irregularidades en que hubiera incurrido la perita oficial, con trascendencia para arribar a conclusiones distintas.

En este sentido, el tribunal casatorio local tiene dicho que *«el peritaje médico-legal se erige como un elemento de ponderación inexcusable y de casi decisiva receptación habida cuenta no sólo de la peculiar entidad de los sucesos sometidos a juzgamiento, sino también de la no apropiada formación de jueces y abogados para entender, en su cabal dimensión, la razón de ser de una concreta actuación médica. Si bien el magistrado no está ineludiblemente obligado a aceptar las conclusiones de los peritos, las que carecen de fuerza vinculante; sólo puede apartarse del dictamen si existen otras pruebas de igual o mayor valor de convicción, o encuentra razones serias y contundentes para considerar que el informe pericial no es convincente»*(TSJ, Sala CyC. Sent. N° 176, 20/12/2018).

III.2.- Del dictamen de la perita oficial se desprende que la muerte de Lola fue el desenlace

de un fatídico proceso iniciado a partir de un primer (y errado) diagnóstico de enfermedad respiratoria.

En segundo término, la perita ha cuestionado en forma fundada el diagnóstico de piometra y, consecuentemente, la necesidad de la ovariectomía practicada, en cuya ejecución se produjo también la extirpación del riñón, previa hemorragia profusa, siendo el shock hipovolémico la causa de muerte de Lola.

En efecto, sintetizando lo informado por la experta:

- a) La demandada no efectuó un examen semiológico completo, ni practicó pruebas complementarias de diagnóstico;
- b) El resultado del laboratorio (análisis de sangre) fue incompleto y no podía ser tomado como un análisis prequirúrgico porque faltaban elementos importantes de la química sanguínea como la determinación de urea en sangre y glucemia;
- c) No había en el expediente *«una ecografía con su informe correspondiente que permita arribar a un diagnóstico (piometra) y por lo tanto su indicación de tratamiento quirúrgico»* (sic), además de que era prácticamente imposible que no hubiera visualizado el riñón izquierdo en la ecografía.
- d) Fue tajante al cuestionar que el diagnóstico de piometra hubiera sido correcto, porque: el análisis de sangre no había sido completo; no era compatible con el registro de celos; la historia clínica no mencionaba síntomas propios de la piometra, como polidipsia, poliuria, dolor abdominal, secreción vaginal y refería una temperatura de 39° C, cuando en general, durante el transcurso de la enfermedad, la temperatura se mantenía normal o era subnormal en una piometra avanzada.

Asimismo, en la audiencia complementaria, la perita oficial reiteró que:

- a) No hubo un diagnóstico certero. La demandada *«actuó a la ligera, pensó que tenía una enfermedad respiratoria, la medicó, después se dio cuenta de que podía ser otra cosa, porque el animal no respondió al tratamiento, cambió de antibiótico, sacó sangre... Faltó en el*

análisis de laboratorio, la determinación de la urea, que es una sustancia que se eleva cuando hay un trastorno renal. En la piometra, que es una enfermedad que se produce en el útero en determinado momento del ciclo estral, se produce una lesión renal y la urea está aumentada. Por lo tanto es un factor importantísimo determinar la urea» (sic);

b) No hubo examen prequirúrgico completo, por lo que no puede afirmarse que Lola hubiera estado debidamente preparada para la cirugía programada;

c) *«Con respecto a la ecografía, es un método complementario... siempre llamamos a personas que estén debidamente capacitadas para hacer las ecografías. Muchos veterinarios tienen en sus veterinarias ecógrafos y hacen ecografías sencillas para descartar alguna patología, pero **en realidad lo que hay que hacer es llamar a un ecografista especializado. El ecografista siempre emite un informe...** el especialista está preparado para diferenciar una patología de un órgano de un artefacto de técnica. Entonces **el informe del ecografista es fundamental y acá no hay.** Simplemente en la ficha que elaboró la veterinaria dice “ecografía – colecta uterina” y nada más. Eso no es un diagnóstico para mí... No tiene mucho sentido hacer una ecografía FAST porque no nos va a dar muchos datos, porque va a tener problemas a la hora de ver cómo están los otros órganos en el abdomen» (el resaltado me pertenece).*

Advierto, además, que al contestar la demanda, la accionada justificó el pedido hecho a la actora de que trajera un paciente donante *«ya que no existía banco de sangre dada la situación del momento (emergencia sanitaria, pandemia)»*, extremo que puede considerarse desmentido con la documental acompañada por la perita oficial (captura de instagram).

Por otra parte, no fue acreditado en autos que al momento de la efectuarse la cirugía, el cuerpo de Lola presentaba adherencias perirrenales, de cuya presencia nada se dice en la historia clínica y que habría llevado a la demandada a tomar la decisión de extirpar también el riñón.

Lo apuntado reviste trascendencia dirimente, pues análogamente a lo que ocurre cuando se

juzga la responsabilidad de quien ejerce la medicina sobre personas humanas, también en materia de responsabilidad veterinaria la historia clínica resulta ser un medio de prueba de capital importancia, cuando se trata de dilucidar la existencia -o no- de mala praxis, porque su confección se debe ir desarrollando a medida que ocurren los acontecimientos que involucran al paciente animal, registrándose en ella la totalidad sucesiva de acontecimientos que facilitarán luego, a quien la analice con ojo crítico, discernir con claridad tanto el fundamento científico de la asistencia brindada, como el cabal cumplimiento de los deberes inherentes a la profesión ejercida. Desde esta perspectiva, se entiende que la inexistencia de historia clínica o la presencia de irregularidades o incompletitudes en la misma, juegan en contra del profesional e invierte la carga de la prueba.

En pocas palabras, las omisiones, deficiencias o irregularidades de las historias clínicas surten una presunción de culpabilidad contra los médicos demandados y provocan una inversión de la carga de la prueba, porque la carencia de datos relevantes en el mentado documento médico o derechamente su falta de agregación al expediente, conducen, las más de las veces, a la imposibilidad de probar la existencia de un comportamiento negligente o desaprensivo del profesional.

Si de tales proposiciones se trata, la demandada no acreditó *positivamente* la necesidad de realizar la nefrectomía

No soslayo tampoco que, en su alegato oral, la defensa de la demandada ha insistido en que no fue probado que la cirugía se efectuara de modo técnicamente incorrecto.

Sin embargo, la mala praxis que con fundamento en la prueba colectada en la causa se le atribuye a la veterinaria accionada se vincula con el desempeño profesional anterior a la práctica de la cirugía y la consiguiente necesidad de esta última.

En efecto, fue categórica la perita oficial al afirmar: *«No consta en el expediente una historia clínica, resultado de un examen semiológico completo, que me permita conocer el estado clínico del animal y el motivo de la consulta. Tampoco consta en el expediente un diagnóstico*

definitivo, informes de pruebas complementarias de diagnóstico (ecografía, radiología) e informes completos de análisis de laboratorio».

A riesgo de ser reiterativo, ya he señalado que la auxiliar cuestionó, en forma fundada, que el diagnóstico de piometra hubiera sido acertado, en razón de que la demandada no realizó la determinación de la urea en sangre, *«fundamental en este caso, ante la sospecha de piometra» (sic)* ni tal estado patológico era compatible con el ciclo estral de Lola de acuerdo al registro de celos. Sobre este último punto, en la audiencia complementaria, la demandada sostuvo que no recordaba haberle consultado a la actora sobre el tema (cfr. minuto 8:29 de la videograbación).

A ello debo añadir que, según la perita oficial, era prácticamente imposible no ver en la ecografía al ovario y riñón izquierdo, como en cambio había manifestado la demandada; quien tampoco efectuó un examen prequirúrgico completo ni confeccionó en debida forma la historia clínica.

Luego, si no puede afirmarse que el diagnóstico de piometra era correcto, tampoco puede considerarse acreditado que fuera necesario someter a Lola a la cirugía de ovariectomía.

Así las cosas, reseñadas las omisiones en que incurrió la demandada, contrarias a la diligencia que le era exigible conforme a las reglas de la *lex artis*; quien no invocó ni probó circunstancias que la excusaran; y acreditada la vinculación causal de dicha negligencia con el deceso de Lola, cabe concluir que la demandada incurrió en mala praxis profesional y debe responder por los daños ocasionados.

IV.- Daño patrimonial: costo de adquisición. La parte actora reclama el *«valor que objetivamente debe padecerse con una perrita de las características de Lola: perra hembra raza caniche Toy blanca que se estipula en el monto de pesos cuarenta mil (\$ 40.000,00), oportunamente en la etapa probatoria será solicitada la prueba informativa correspondiente a los fines de corroborar este el monto reclamado» (sic).*

IV.1.- El rubro es de recibo, pues en la hipótesis de que el animal fallezca -tal el caso de Lola- la cantidad a resarcir será su valor.

La doctrina plantea que no es tarea fácil determinarlo, ya que atendiendo al trato de propiedad que la normativa otorga a la relación entre animal y dueño del mismo, cabe remitirse al valor de mercado, pero es dable preguntarse si este valor se refiere a un animal sano o enfermo –en función de la dolencia que le hubiera conducido al veterinario–. Los autores se decantan por el segundo, aunque corregido con el valor del animal que, habiendo sido tratado adecuadamente, se hubiera recuperado (cfr. Monterroso Casado, Esther: *Aspectos legales y responsabilidades derivadas de la práctica veterinaria*; Servet, 2005, pp. 141 y ss.; Gil Membrado, Cristina: *Régimen jurídico civil de los animales de compañía*, Dykinson, 2014, p. 273).

IV.2.- Ahora bien, al evacuar el requerimiento formulado, el Sr. Roberto Gnunes, vicepresidente del Caniche Club Argentino, informó que en razón de su objeto, la institución, era ajena a cualquier tipo de transacción económica, por lo que no podía informar el precio actual de un caniche toy sin pedigrí hembra blanco.

No obstante, no luce ajustado a Derecho que, demostrada la existencia de un daño, atribuible causalmente a la parte demandada, ante la existencia de un hecho antijurídico, quedaran los detrimentos sin resarcimiento por el defecto de prueba directa sobre el monto (C1CC Cba., Sent. N° 31, 07/04/2022).

Tal temperamento tiene el respaldo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: «Si se resolvió el rechazo de la demanda por daños y perjuicios -en la especie- por ausencia de prueba del monto del daño sufrido, el tribunal ha venido a admitir la existencia del mismo; en tales condiciones, y teniendo en cuenta las amplias facultades de los jueces en orden a la estimación y valoración de aquellos, resulta autocontradictorio tener por acreditada la existencia del daño y negar toda compensación por no considerar probado su monto. Por consiguiente, el pronunciamiento carece de suficiente fundamentación, lo cual lo torna

descalificable como acto jurisdiccional válido y es susceptible de ser atacado en los términos de la doctrina de la arbitrariedad» (CSJN, “Bellizzi, José S. y otros v. Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado”, 31/10/1985, JA 1986-III-424).

El extremo fundamental del juicio de daños, es, precisamente, la configuración de un perjuicio resarcible. Pero, en cambio, la medida del concreto resarcimiento, no reviste entidad autónoma de significación tal que autorice, de por sí, a desestimar la pretensión, en tanto sea factible la estimación prudencial por el juez o la indagación complementaria en un momento ulterior del mismo proceso -ejecución de sentencia-, tal como lo prevén los arts. 333 a 335 del CPCC.

La aplicación de esta normativa procesal debe guardar armonía con el ordenamiento jurídico en su integridad, especialmente, con los superiores valores que anidan en la base del principio «*alterum non laedere*» y el derecho a la reparación integral, ambos complementarios y de raíz constitucional (art. 19 CN; CSJN, “Ontiveros, Stella Maris c. Prevención ART S.A. y otros s/ accidente - inc. y cas”, 10/8/2017, LL 23/08/2017).

Correctamente se ha sostenido que «*la medida de una indemnización es sólo una circunstancia de magnitud (el ‘cuánto’) de una esencia reconocida y comprobada (el ‘qué’: procedencia jurídica del resarcimiento). Aquella medida atañe a la justicia que debe satisfacer la indemnización (la cual no debe pecar ni por exceso ni por defecto); pero este problema no puede volverse en contra de la justicia prioritaria del derecho del damnificado a obtener un resarcimiento que restituya el equilibrio jurídico alterado por el supuesto perjudicial*» (Zavala de González, Matilde: *Resarcimiento de daños*, Hammurabi, 1993, t. 3, p. 343/344).

Por otro lado, si se encuentran acreditados menoscabos patrimoniales, es inadmisibile aseverar que no hay ningún dato cuantitativo, ya que todos se caracterizan por ser susceptibles de apreciación pecuniaria. De allí que, como regla, probar el daño es probar también una disvaliosa repercusión económica, aunque a veces sea sin precisión.

La reparación es inherente a toda producción indebida de un daño y resultaría inadmisibile no condenar por no saber exactamente cuánto, pues alguna indemnización corresponde, cualquiera sea el derrotero técnico que se implemente para cuantificarla (vg., estimación prudencial, diferimiento de la determinación al estadio de ejecución de sentencia, etc.). De otra manera, el rechazo de rubros indemnizatorios no se dictaría por ausencia de algún presupuesto resarcitorio sino a título de castigo por la falencia probatoria relativa al monto. En tal sendero, constituiría un verdadero retroceso desandar el camino recorrido para descartar criterios sancionatorios en la función resarcitoria de la responsabilidad civil si ellos, paradójicamente, volvieran a introducirse para decidir la no reparación de daños, pese a ser ciertos.

Se añade que la equidad cumple una función esencial en la aplicación del derecho, lo que significa que el juez debe adecuar la norma al caso concreto con un sentido de justicia, atemperando su excesivo rigor o adaptándola, conforme el criterio valorativo de las circunstancias del caso, cuando ésta sea imprecisa, injusta o insuficiente.

Entonces, la equidad -en tanto recurso tendiente a morigerar las injusticias que podrían derivarse de una norma jurídica general, en oportunidad de su aplicación al caso concreto- en atención a las especiales circunstancias de la presente causa, impone medir la rigurosidad del sistema adjetivo en las hipótesis en que el interesado no acredita el monto por el cual procede el resarcimiento (arts. 333, 334 y 335, CPCC).

A la luz de tales directrices, encontrándose probado el daño patrimonial de la actora, corresponde diferir para la etapa de ejecución de sentencia, la determinación del precio actual de un caniche toy, sin pedigrí, hembra, blanco, de seis años de edad.

V.- Daño patrimonial: Gastos Médicos. Por atención veterinaria y estudios médicos, la parte actora solicita el reembolso de la suma de \$ 3.900.

Estimo que el rubro luce procedente por el monto indicado, teniendo en cuenta el carácter frecuentemente oneroso de tales servicios; la documental adjuntada en la operación

electrónica de fecha 31/03/2023, consistente en resúmenes de cuenta de la tarjeta VISA y tickets de débito por la suma de \$ 1.900 a favor de “Hakuna Matata” y estudios de laboratorio.

De otro costado, como es sabido, para recibir este capítulo no es necesaria la efectiva prueba de los desembolsos realizados, cuando por la índole de los hechos juzgados y sus consecuencias se presume que tales gastos se han debido realizar.

El monto señalado devengará intereses desde el 13/07/2020 por aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del BCRA, con más los siguientes adicionales: i) Hasta el día 30/06/2022, 2% nominal mensual; ii) Desde el 01/07/2022 al 31/12/2022, 2,5% nominal mensual; iii) Desde el 01/01/2023 al 31/07/2023, 3% nominal mensual, y iv) Desde el 01/08/2023 hasta el efectivo pago, 5% nominal mensual.

VI.- Daño patrimonial: Gastos por costas de prueba anticipada. Por este rubro la actora pretende ser resarcida por la suma de \$ 18.316.

Dado que este ítem integra la condena en costas, me remito a lo que más adelante se resuelve sobre el punto.

VII.- Daño moral. La actora persigue la indemnización del daño moral sufrido a causa del fallecimiento de Lola.

VII.1.- Como regla general, no es dable presumir que exista un necesario interés legítimo de afección conexo a la posesión o disfrute de bienes patrimoniales, incluidos los animales. Ello porque, sin perjuicio de su valor de cambio o de uso, es contingente la circunstancia de que la propiedad, posesión o utilización de tales bienes refleje por sí misma un trasfondo afectivo autónomo de sus implicancias económicas y utilitarias. No se ignora que cualquier persona puede “sufrir” ante la lesión de sus bienes, pero no es el sufrimiento en sí lo que se resarce, sino en tanto en cuanto se advierta la lesión a un interés extrapatrimonial digno de tutela jurídica (cfr. Zannoni, Eduardo: *El daño en la responsabilidad civil*, Astrea, 1987, p. 439). El daño moral no es el dolor, la pena o la angustia, sino la minoración espiritual derivada de la

lesión de un interés no patrimonial. No cualquier incomodidad, inconveniente o preocupación constituyen daño moral en el sentido de la ley.

Tratándose de eventos lesivos que privan de bienes o servicios materiales, la procedencia del daño moral requiere que haya un interés de afección vinculado con su propiedad o disfrute, el cual debe tener sustancia espiritual, autónoma de su valor económico (cfr. Zavala de González, Matilde: *Resarcimiento del daño moral*, Astrea, 2009, p. 509). De lo contrario, todo daño patrimonial conllevaría el resarcimiento automático de un perjuicio moral que podría no existir, con el consiguiente enriquecimiento injustificado en cabeza del damnificado.

VII.2.- En el caso, la actora ha probado las circunstancias especiales que ligaban el goce de la compañía de Lola con sus afectos, en tanto integrante de su familia, por lo que el daño moral surge indudable en autos (cfr. Zavala de González, Matilde: *Resarcimiento del daño moral*, Astrea, 2009, pp. 275, 281 y 509).

En sentido aquiescente, se ha resuelto que en los supuestos de muerte de la mascota por mala praxis profesional, la procedencia del daño moral se funda en que la patrimonialidad de la prestación no excluye la extrapatrimonialidad del interés del acreedor, ya que una cosa es el contenido de la prestación y otra distinta son los intereses o bienes que resultan afectados por el incumplimiento de la obligación. Estos bienes o intereses conculcados pueden ser de naturaleza no patrimonial, como acontece cuando fallece la mascota de la familia, pues aquí el daño moral resarcible se vincula con el derecho que tiene el damnificado al goce de los bienes debidos a la afección por las cosas (C2CC. Cba., “Ontiveros, Karina c/ Seita, Néstor D.”, 11/04/2002, LLC 2002, 1043; C2CCMPyT. Mendoza, “Gallardo, Heidi María de los Ángeles c. Bruno, Andrea s/Daños y perjuicios”, 01/04/2014, Rubinza On Line, RC J 3857/14).

VII.3.- Siguiendo este orden de ideas, el resarcimiento del daño moral exige, como medida previa, una valoración del daño en concreto a fin de individualizarlo, lo que implica justipreciar las repercusiones que la lesión infirió en el ámbito subjetivo de la víctima, a partir

de las circunstancias objetivas y subjetivas del caso.

Así, *«se deben considerar el vínculo afectivo entre el dueño y el animal, situación que se comprueba con claridad en los casos de la realización de hechos lesivos a las mascotas. Estos casos generan un daño moral para el damnificado, cuya presunción es mayor cuanto más cercana y fuerte es la relación entre ambos. A tal efecto, la circunstancia de que el propietario sea una persona que vive en compañía de su mascota, se trata de una persona discapacitada, específicamente, con ceguera absoluta, o anciana, o sola, como así también el tiempo de duración del nexo entre ambos, incidirán, de manera notoria y decisiva, en la determinación del monto indemnizatorio, con autonomía del valor material que, específicamente, tenía el ejemplar afectado»* (Fumarola, Luis A.: *Incidencias del Código Civil y Comercial. Responsabilidades profesionales y especiales*, Hammurabi, 2016, p. 411).

Por otro lado, el art. 1741 del actual CCyCN establece que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.

No obstante, la propia naturaleza espiritual del daño moral impide efectuar una cuantificación netamente objetiva, incluso si se apela al criterio de los placeres compensatorios receptado por el Código de fondo, por lo que queda librada al criterio prudencial de los jueces, según las reglas de la sana crítica racional (cfr. TSJ, Sala CyC., “Torrez, Elvio Aldo C/ Altamirano, José Daniel y otro –Ordinario – Daños y perj. – Accidentes de tránsito – Recurso de casación”, Sent. N° 129, 26/08/2014).

Ocurre que no es factible comparación alguna (mucho menos, equivalencia) entre un menoscabo espiritual y una indemnización dineraria. Para los tribunales representa una extrema dificultad la estimación de este rubro, pues tratándose de vivencias personales, no puede saberse con certeza cuanto sufrió la damnificada a raíz del suceso, ni la repercusión en sus sentimientos que fueron consecuencia del hecho bajo juzgamiento, pudiendo solo evaluar la magnitud del menoscabo que puede provocar el hecho en el común de las personas,

valorándolo a la luz de las circunstancias particulares acreditadas en la causa: *«La dificultad en calibrar los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible las angustias, inquietudes, miedos y padecimientos por la situación vivida... Si se trata de daños espirituales, extrapatrimoniales, morales o como se los quiera denominar, pero que no son tangibles, la labor del juez se encuentra limitada a una apreciación subjetiva, de introspección y empatía. Aun así, jamás perfecta; solo de aproximación, pues el sustrato de lo espiritual es tan personal y subjetivo que es imposible introyectarlo directa y certeramente, existiendo solo una referencia cercana y parámetros racionales»* (Samuel, Osvaldo M.: *El daño moral en el Código Civil y Comercial*, Astrea, 2019, p. 111).

VII.4.- A la luz de estas pautas, a fin de calibrar el impacto que el hecho tuvo en la persona de la Sra. Marrero, tengo en consideración que era propietaria de Lola desde su mes y medio de vida (siendo su fecha de nacimiento el día 20/07/2014).

Desde entonces la actora vivió en compañía de su mascota, a la que responsablemente prodigó los cuidados correspondientes, conforme surge de la copia del carnet sanitario, certificados de vacunación y desparasitación y contratación de prepaga de salud animal, todo lo cual da cuenta del enorme afecto que la actora y su familia profesaban por Lola y del shock que presumiblemente les provocó su muerte imprevista a raíz de lo que en un primer momento se presentó como una operación programada de castración.

Asimismo, con fecha 16/02/2024 se incorporó el dictamen de la perita oficial psicóloga María Laura Vassallo.

Respecto al estado psicoemocional de la actora a raíz del fallecimiento de Lola y situación actual individual y familiar, la experta concluyó: *«La pérdida de la mascota fue acompañada de varias emociones, angustia, tristeza y bronca, en este caso estos indicadores existieron en simultaneo con un gran sentimiento de culpa, pues considera haber tomado una mala*

decisión al permitir que operaran a su perra, haciendo conjeturas sobre qué hubiera pasado si esto no se realizaba, poniéndose en una posición de mucho más dolor y sufrimiento.

Se visualiza un profundo sentido de pérdida. Pues el animal en esta familia tenía un lugar especial, a la vez que era una compañía importante para la madre de la actora la cual tiene hoy 81 años. El cuidado y la atención que se le brindaba eran significativos.

Hay un duelo que se generó a partir de esta pérdida lo que implicaría un trabajo psíquico a fin de poder superar el dolor padecido.

El lugar que se le daba a la mascota en el seno familiar era relevante, se consideraban sus necesidades (salud, aseo), se procuraba que tuviera su espacio (lugar específico para que dormir y comer) se le brindaba atención y cariño.

Se habría construido un lazo en el cual se depositaban emociones de afecto en el animal, según lo relatado en la pericia la responsabilidad, compromiso y cuidado hacia Lola era continuo y sostenido en el tiempo, un miembro más del hogar.

Con el fallecimiento de misma, comenzaron a aflorar sentimientos de pérdida en la peritada (tristeza, inquietud) como también según lo relatado por la Sra. Marrero, en su madre apareció cierto desgano, momentos de angustia y cuestionamientos hacia ella por haberla llevado a ese lugar.

Otras sensaciones surgieron luego de que la médica veterinaria le enviara una carta documento pidiendo que se abstuviera de hablar de ella, lo cual dijo indignarla, pues a la pérdida Lola se sumó la cuestión legal que implicó todo un gasto de energía psíquica extra.

La peritada al relatar el actuar de la Dra. Belén Díaz, luego del fallecimiento de Lola, refiere haberse sentido movilizada, recuerda haber sido insultada y amenazada, “me envió una carta documento”.

Este tipo de comportamientos más bien del orden de lo disruptivo afectan, movilizan y activan miedos, así como también la necesidad de protegerse frente a factores externos poco favorables».

VII.5.- Acorde a su naturaleza de deuda de valor, el monto indemnizatorio del daño moral debe ser establecido a la fecha de la presente resolución, a fin de evitar que la distorsión altamente significativa de las sumas dinerarias durante la mora del deudor -el tiempo el transcurrido entre la producción del daño y el efectivo cumplimiento de la condena- perjudique a la víctima, por la depreciación que pueda experimentar el monto resarcitorio reconocido en un grave, público y notorio contexto inflacionario.

Con ajuste a lo expresado, reconocida la existencia del perjuicio espiritual invocado y su gravedad, admitida la dificultad que supone cuantificar un rubro de tan especial naturaleza, pero a la luz de lo que nos permite conocer el expediente, se justifica acabadamente a mi juicio la decisión de establecer la condena por daño moral en la suma pesos cuatrocientos mil (\$ 400.000), por resultar un monto apto para alcanzar satisfacciones (v.g., compra de determinados bienes, realización de actividades de diverso orden, etc.) que compensen la incidencia de la gravedad probada del menoscabo espiritual en la vida de la damnificada. Los intereses de rubro se calcularán a razón del ocho por ciento (8%) anual desde el 13/07/2020 hasta la presente resolución, y de aquí en adelante, se determinarán mediante la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA, con más el 5% nominal mensual. Esta discriminación en la tasa aplicable persigue evitar la distorsión económica de la doble “actualización” que operaría si se fijara el monto indemnizatorio a valores correspondientes a la fecha del dictado de la presente sentencia y los accesorios del período anterior se calcularan mediante la aplicación de la tasa que contendría escoria inflacionaria.

Finalmente, la solución expuesta no implica infringir el principio de congruencia. En efecto, si la parte actora -sin incurrir en un ejercicio irregular o abusivo de sus derechos- anticipa que el monto económico de su pretensión está subordinado al resultado de la prueba o del prudente arbitrio judicial -jugando este último un rol preponderante en la cuantificación del daño moral- el tribunal debe pronunciar la condena por un monto adecuado a ésta, así sea inferior o superior al evaluado interinamente en la demanda.

En sentido coincidente, el Tribunal Superior tiene dicho que cuando en la demanda la parte actora enuncia un monto provisorio en la apreciación pecuniaria del daño e incluye la fórmula de práctica «o lo que en más o en menos resulte de la prueba», o alguna otra expresión equivalente, al dictar sentencia los jueces deben condenar al responsable en función del valor económico que surja de las probanzas instruidas en el juicio y a las que en forma preventiva se aludió en el escrito de introducción, y a la inversa deben prescindir de aquella estimación puramente interina y condicionada. Al decidir de esa manera los magistrados no transgreden el requisito de congruencia que en nuestro sistema procesal delimita y acota sus potestades decisorias, sino que al contrario lo observan y acatan habida cuenta de los términos amplios y flexibles con que el propio accionante designó el objeto mediato de la acción (conf. TSJ, Sala CyC, sentencias N° 23/86, N° 57/07 y N° 157/11, entre muchas otras).

VIII. Intereses. El capital objeto de condena devengará los intereses determinados en los Considerandos respectivos.

Al respecto, no desconozco el criterio sentado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia en el precedente “Seren Sergio Enrique C/ Derudder Hermanos SRL – Ordinario – Despido - Recurso Directo - Expte. N° 3281572” (Sentencia N° 128 del 01/09/2023).

Sin embargo, considero que a los fines de paliar adecuadamente los efectos de la inflación que innegablemente afecta la economía nacional, la cual lejos de mantenerse invariable, se ha incrementado sustancialmente sobre todo con posterioridad a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias llevadas a cabo en nuestro país en agosto del año pasado, a punto tal que en la actualidad se registra un índice inflacionario mensual de dos dígitos, que impacta fuertemente, y de manera especial, en el precio de artículos de primera necesidad como alimentos y bebidas, realidad ésta que no puede ser soslayada de ninguna manera por la jurisdicción, se impone necesariamente fijar una tasa de interés superior a la establecida en el citado precedente, tal como se propicia en estos autos y a fin de no licuar el crédito del acreedor y compeler al deudor a satisfacer la condena y así evitar que le resulte más

beneficioso incumplir con su obligaciones.

IX. Costas. Las costas se imponen a la demandada en virtud de resultar vencida (art. 130 CPCC), con excepción de los honorarios de los peritos de control cuyos obligados al pago serán sus respectivas partes proponentes.

X.- Honorarios. A mérito de no existir base regulatoria definitiva, difiérase la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad (arts. 26 y 49, ley 9459).

Por todo lo expuesto

RESUELVO:

- I)** Hacer lugar a la demanda promovida por la Sra. Maria Sol Marrero en contra de la Sra. María Belén Díaz (DNI 27.655.581) y, en consecuencia, condenar a la demandada a abonar:
- a) La suma que, en etapa de ejecución de sentencia, surja de la determinación del precio actual de un caniche toy, sin pedigrí, hembra, blanco, de seis años de edad; b) El monto de \$ 3.900 en concepto de reembolso de gastos de atención veterinaria y estudios médicos; c) La suma de \$ 400.000 a título de indemnización del daño moral; todo con más los intereses establecidos en los Considerandos respectivos;
- II)** Imponer las costas a la demandada, con excepción de los honorarios de los peritos de control cuyos obligados al pago serán sus respectivas partes proponentes;
- III)** Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.

Protocolícese y hágase saber.

Texto Firmado digitalmente por:

VILLARRAGUT Marcelo Adrián

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.03.21